

UNIVERSIDAD CATÓLICA SEDES SAPIENTIAE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD



Nivel de Conocimiento y adherencia al tratamiento
antihipertensivo **en adultos en un** Centro de Salud Público,
Lima - 2025

**PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PARA OPTAR EL
TÍTULO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA**

AUTORAS:

De la Cruz Rodriguez, Herminia
Mercado Sarmiento, Judith

ASESORA:

Mg. Guillermina Valdivia Arce

Lima, Perú
2025

RESUMEN

Objetivo: Determinar la relación que existe entre el nivel de conocimiento de la hipertensión y adherencia al tratamiento antihipertensivo en adultos de un Centro de Salud Público, Lima – 2025. **Materiales y métodos:** la investigación tendrá un enfoque cuantitativo, con un diseño descriptivo no experimental y de corte transversal, utilizando el método correlacional. La población estará conformada por 750 pacientes al Centro de Salud durante un trimestre. La muestra será seleccionada de forma no probabilística por conveniencia, compuesta por 150 adultos diagnosticados con hipertensión arterial en dicho centro. Para la recolección de datos se empleará la técnica de la encuesta, mediante dos cuestionarios diseñados por las investigadoras. El primero evaluará el nivel de conocimiento sobre la hipertensión, validado a través del coeficiente Kuder Richardson, y el segundo medirá la adherencia al tratamiento, utilizando la prueba Alfa de Cronbach. La relación entre las variables se analizará mediante la prueba de correlación de Spearman. Ambos instrumentos validados por 10 jueces expertos. **Ventajas:** El diseño del estudio permitirá realizar la investigación en un periodo corto, optimizando los recursos humanos, materiales y financieros, lo que reducirá los costos del proyecto. Además, la accesibilidad directa a la población objetivo, gracias a que una de las investigadoras forma parte del personal del centro de salud, facilitará la coordinación con los responsables de establecimiento. **Limitaciones:** una limitación potencial del estudio es la posible ausencia de pacientes hipertensos en los días asignados para la aplicación de la encuesta.

Palabras claves: Hipertensión arterial, Conocimiento, Adherencia al tratamiento.

ABSTRACT

Objective: To determine the relationship between the level of knowledge of hypertension and adherence to antihypertensive treatment in adults at a Public Health Center, Lima - 2025. **Materials and methods:** The research will have a quantitative approach, with a non-experimental and cross-sectional descriptive design, using the correlational method. The population will be made up of 750 patients at the Health Center during a quarter. The sample will be selected in a non-probabilistic way for convenience, composed of 150 adults diagnosed with arterial hypertension at said center. For data collection, the survey technique will be used, through two questionnaires designed by the researchers. The first will evaluate the level of knowledge about hypertension, validated through the Kuder Richardson coefficient, and the second will measure adherence to treatment, using the Cronbach Alpha test. The relationship between the variables will be analyzed using the Spearman correlation test. Both instruments validated by 10 expert judges. **Advantages:** The study design will allow the research to be carried out in a short period of time, optimizing human, material and financial resources, which will reduce the costs of the project. In addition, direct access to the target population, thanks to the fact that one of the researchers is part of the health center staff, will facilitate coordination with the facility managers. **Limitations:** A potential limitation of the study is the possible absence of hypertensive patients on the days assigned for the application of the survey.

Keywords: Arterial hypertension, knowledge, Adherence to treatment.

ÍNDICE

RESUMEN	ii
ÍNDICE	iv
INTRODUCCION	vi
CAPÍTULO I. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	6
1.1.	6
1.2.	8
1.2.1	8
1.2.2	8
1.3	8
1.3.1	8
1.3.2 Justificación Práctica	8
1.3.3 Justificación Metodológica	8
1.4.	9
1.4.1	9
1.4.2 Objetivos específicos	8
1.5. Hipótesis	8
1.5.1	9
1.5.2 Hipótesis Nula	8
CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO	9
2.1	10
2.1.1	10
2.1.2.	11
2.1.3	12
2.2. Bases teóricas	11
2.3	13
CAPÍTULO III. MATERIALES Y MÉTODOS	19
3.1	23
3.2	23
3.3	23
3.4	24
3.4.1 Definición conceptual y operacionalización de variables	20
3.5	26
3.6	28
3.7	28
3.8	29
3.9	29
3.10. Cronograma de actividades	5
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	5
ANEXOS	5

INTRODUCCIÓN

La Hipertensión Arterial (HTA) se reconoce como un problema de salud pública creciente, con una prevalencia cada vez mayor a nivel global, lo que requiere una atención urgente. Esta enfermedad es causada por una variedad de factores socioeconómicos, culturales, étnicos, genéticos y ambientales. Y representa un riesgo significativo para la salud de los individuos. Según un informe reciente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una proporción considerable de los pacientes hipertensos no recibe un tratamiento adecuado. Este informe destaca que la HTA afecta a uno de cada tres adultos en el mundo, y se asocia con graves complicaciones de salud, tales como infartos y accidentes cerebrovasculares. Desde 1990, el número de casos ha aumentado considerablemente, y la OMS enfatiza que, mediante el acceso mejorado al tratamiento y la implementación de cambios en los estilos de vida, podrían evitarse hasta 76 millones de muertes entre 2023 y 2050. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) indica que, en América Latina, más de 1.6 millones de personas padecen de esta enfermedad, afectando tanto áreas urbanas como rurales. La HTA se considera una de las principales causas de muerte por complicaciones cardíacas y cerebrales, siendo la segunda causa más frecuente de discapacidad a nivel mundial. (1-4).

Según el informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 21,7% de los peruanos mayores de 15 años padece hipertensión arterial, de los cuales el 68,0% recibió tratamiento durante el año 2020. En cuanto a la distribución por sexo, el 24,5% de los hombres y el 19,1% de las mujeres en el país presentan esta enfermedad. La hipertensión arterial es desencadenada por diversos factores, entre los que se incluyen los malos hábitos alimentarios, la falta de actividad física, los antecedentes familiares, lo que resalta la importancia de estrategias de prevención y tratamiento adecuadas para mitigar su impacto en la población. (5,6)

La adherencia al tratamiento es un factor clave para mejorar la calidad de vida de las personas con HTA, ya que permite prevenir complicaciones a largo plazo. En este sentido, la promoción y prevención juegan un papel fundamental en orientar a los pacientes hacia una adherencia óptima al tratamiento. La labor del personal de enfermería es esencial en este proceso, ya que se fundamenta en un conjunto de conocimientos científicos, técnicos, éticos y jurídicos, así como en el desarrollo de habilidades y actitudes positivas que favorecen la educación y acompañamiento de los pacientes en su proceso de tratamiento. Este enfoque integral contribuye a una mejor gestión de la HTA y a la reducción de riesgos asociados a la enfermedad.

La presente investigación se organiza en cinco capítulos. El primer capítulo aborda la situación problemática, describiendo de manera detallada la realidad de la HTA, una enfermedad que ha mostrado un aumento significativo año tras año, y que deja secuelas importantes en la población afectada. El segundo capítulo, presenta una revisión de investigaciones internacionales, nacionales y locales relacionadas con la hipertensión, seguida de un marco teórico en el que se expone la evolución de la comprensión y tratamiento de la enfermedad a lo largo de historia. Se incluye también la definición de la hipertensión, sus principales síntomas, los factores de riesgo asociados, así como las

descripciones y definiciones de las variables claves del estudio: conocimiento, adherencia y sus respectivas categorías.

El tercer capítulo describe el tipo de estudio y diseño metodológico, utilizando, la población objetivo, los criterios de inclusión y exclusión, además de los aspectos éticos y económicos que guían la investigación. También se incluyen las referencias bibliográficas que sustentan el trabajo. Se presenta la matriz de consistencia, la cual establece los objetivos y los factores socioeconómicos involucrados. Asimismo, se detalla el plan de recolección de datos, los instrumentos de medición empleados y el cuadro de operacionalización, en el que se definen las variables primarias y secundarias, junto con sus dimensiones, categorías e indicadores. Finalmente, se describen los instrumentos de medición utilizados para evaluar el conocimiento y adherencia al tratamiento, así como el consentimiento informado y las evidencias de validación por parte de jueces expertos en hipertensión arterial.

CAPÍTULO I. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. Situación problemática

La Hipertensión Arterial (HTA) es una condición médica caracterizada por la elevación sostenida de la presión arterial, que afecta de manera significativa la salud pública a nivel mundial. Este trastorno representa un riesgo considerable para diversos órganos, como el cerebro, el corazón y los riñones, ya que, si no se mejora adecuadamente, puede generar complicaciones graves, como infartos, accidentes cerebrovasculares y daño renal. La HTA es particularmente preocupante debido a su naturaleza silenciosa; en sus etapas iniciales, muchas personas no presentan síntomas evidentes, lo que dificulta su diagnóstico y tratamiento oportuno. Esta falta de síntomas en fase tempranas contribuye a que una gran parte de la población no sea consciente de su condición, lo que aumenta el riesgo de complicaciones severas a medida que avanza la enfermedad. (1)

La Fundación Española del Corazón (FEC), describe a la HTA, como un problema de salud pública global de gran envergadura, ya que, ocasiona aproximadamente 7.5 millones de muertes al año, lo que representa el 13% del total de muertes originadas por enfermedades no transmisibles. La prevalencia de la HTA varía entre países y regiones, siendo un factor predisponente la edad, ya que el 65% de los casos corresponden a adultos mayores de 60 años. En países desarrollados como Canadá, Corea y Estados Unidos, la prevalencia de hipertensión se encuentra alrededor del 29%, mientras que, en naciones como Suiza, Dinamarca, Nueva Zelanda, Singapur, y Perú entre otros, la proporción alcanza el 35% de la población. En Europa Occidental, países como Noruega, Portugal, Irlanda y Finlandia presentan tasas cercanas al 40%. Sin embargo, los niveles de hipertensión más altos se observan en África, donde, con excepción de Egipto, países como Mozambique I (50,9%) y Nigeria (52,3%) reportan tasas alarmantes de hipertensión. Esta elevada prevalencia mundial subraya la importancia de adoptar estrategias de prevención y tratamiento adecuadas, ya que la HTA es un factor de riesgo significativo para enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y renales, que tienen un impacto directo en la morbilidad y mortalidad de la población. (1)

La hipertensión arterial representa un grave problema de salud pública, especialmente en América Latina, donde, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), 1.6 millones de muertes son atribuibles a enfermedades cardiovasculares, de las cuales medio millón se deben a la hipertensión. Los pacientes diagnosticados con HTA tienen edades que oscilan entre los 30 y 79 años, y la mayoría proviene de países con ingresos económicos medianos y bajos, lo que refleja una alta vulnerabilidad en estos contextos. Las principales causas de mortalidad asociadas a la HTA en la región incluyen los accidentes cerebrovasculares (ACV), responsable del 51% de las muertes, seguida de enfermedades cardíacas, que representan el 45%. La situación es particularmente preocupante, ya que la HTA es una enfermedad silenciosa, que muchas veces no presenta síntomas evidentes, lo que dificulta su diagnóstico temprano y tratamiento adecuado. La falta de acceso a servicios de salud, la insuficiente educación sobre la enfermedad y la baja adherencia a los tratamientos son factores que contribuyen a la

alta tasa de mortalidad, lo que subraya la necesidad urgente de implementar estrategias de prevención, diagnóstico y manejo oportuno de la hipertensión en los países de la región. (2)

La Hipertensión Arterial (HTA) es reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial, Constituyendo la segunda enfermedad más prevalente globalmente. La HTA es la principal causa de enfermedades isquémicas cardíacas y accidentes cerebrovasculares, infarto al miocardio y daños renales. Lo que resalta su impacto devastador en la salud pública. Según el informe de la OMS, cuatro de cinco personas con hipertensión no reciben tratamiento adecuado, lo que contribuye significativamente a la alta tasa de mortalidad asociada a esta enfermedad. Si la cobertura de tratamiento en los países fuera más amplia y accesible, se podrían prevenir hasta 76 millones de muertes entre 2023 y 2050. Actualmente, uno de cada tres adultos en el mundo padece hipertensión, y este número se ha duplicado entre 1990 y 2019, pasando de 650 millones a 1300 millones de personas con hipertensión que desconocen su condición. Este problema es particularmente grave en países de bajos recursos económicos, donde la falta de acceso a servicios de salud adecuados y el desconocimiento sobre la enfermedad agravan la situación, evidenciando la urgente necesidad de estrategias de prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno. (3)

En Perú, la hipertensión arterial presenta una prevalencia considerable entre la población mayor de 15 años, con una distribución desigual en las diversas regiones del país. Según datos del 2019, las provincias con mayor prevalencia de HTA son la Provincia Constitucional del Callao con un 17,7%, seguido por Piura (16,6%), Lima provincia (16,5%), Ica y Lima región con un (15,8%) Y Tacna (15,6%). En contraste, los departamentos con los niveles más bajos son: Junín (9,5 %), Huancavelica (8,0%) y Ucayali (6,8%). A pesar de la alta prevalencia, solo el 68,1% de los adultos diagnosticados con hipertensión recibe tratamiento adecuado, siendo el porcentaje mayor en mujeres (70,2%) en comparación con los hombres (65,0%). En cuanto a la distribución geográfica del tratamiento, la mayor parte de los pacientes que reciben medicación se encuentran en Lima Metropolitana (73,9%), seguida por la costa (71,3%), la selva (65,4%) y la sierra (54,0%). Estos datos reflejan disparidades regionales tanto en la prevalencia de la enfermedad como en el acceso al tratamiento, lo que resalta la necesidad urgente de mejorar las estrategias de diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la hipertensión, especialmente en las regiones con menor cobertura y en las poblaciones más vulnerables. (4)

En el 2020, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la prevalencia de hipertensión arterial en la población peruana mayor de 15 años aumentó al 21,7%, con una mayor afectación en los hombres, quienes presentaron una tasa del 24,5%, frente al 19,1% en mujeres. A pesar de la alta prevalencia, solo el 68,0% de las personas diagnosticadas con HTA recibieron tratamiento adecuado. Esta situación revela una brecha significativa entre el número de personas afectadas por la enfermedad y la cantidad que recibe la atención necesaria, lo que incrementa el riesgo de complicaciones graves. (5)

Según un informe del Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR) de 2022, que incluyó a 29,422 adultos de ambos sexos (52,1% mujeres y 47,9% hombres) entre los 30 y 59 años, la prevalencia de HTA fue del 21,6% en los hombres. Sin embargo, los grupos

más afectados son los adultos mayores de 60 años, con una prevalencia del 35,3%. Las áreas más impactadas son Lima Metropolitana, con una tasa del 22,1%, y las zonas urbanas en general, donde se registra un 18,2%. Esto se debe, en gran parte, a los estilos de vida en las zonas urbanas, donde la exposición al tabaco, el consumo excesivo de alcohol, la falta de tiempo para la actividad física y una alimentación desequilibrada son factores predominantes. (6)

Durante una visita al centro de salud de Surquillo, se observó que muchos pacientes diagnosticados con HTA, desconocen su condición, lo que afecta su capacidad para controlar su presión arterial de manera regular. Este desconocimiento se refleja en la falta de adherencia a los tratamientos, ya que los pacientes mencionan que los medicamentos les provocan malestares estomacales, prefiriendo recurrir a plantas curativas como alternativa. Esta situación ha causado un incremento significativo de la hipertensión entre los pacientes de este centro de salud. Ante este panorama surgen varias interrogantes: ¿Cuál es la relación entre el nivel de conocimiento y la adherencia al tratamiento? ¿No conocer las consecuencias de no tratar la hipertensión de manera médica influye en la adherencia al tratamiento? ¿Es posible emplear métodos de enfermería para mejorar la adherencia al tratamiento? ¿Existen factores sociodemográficos que inciden en esta problemática? El propósito de esta investigación es identificar el nivel de conocimiento de los usuarios sobre la hipertensión y cómo este influye en su adherencia al tratamiento antihipertensivo.

1.2. Formulación del problema

1.2.1 Problema general

¿Cuál es la relación entre el nivel de conocimiento de la Hipertensión arterial y la adherencia al tratamiento antihipertensivo en adultos en un Centro de Salud Público, Lima - 2025?

1.2.2 Problemas específicos

- ¿Cuál es el nivel de conocimientos sobre la Hipertensión arterial en adultos en un Centro de Salud Público, Lima - 2025?
- ¿Cuál es el nivel de adherencia del tratamiento antihipertensivo en adultos en un Centro de Salud Público, Lima - 2025?
- ¿Cuáles son las características sociodemográficas de los pacientes diagnosticados con hipertensión arterial que asisten al Centro de Salud Público, Lima – 2025?

1.3 Justificación del tema de la investigación

1.3.1 Justificación Teórica

Desde el punto de vista teórico realizamos esta investigación porque a pesar que existen otros estudios sobre este tema, no se ha realizado con las variables de conocimientos y adherencia en adultos mayores de 18 años en un centro de salud público de Lima, es por tal motivo que este estudio llenará un vacío en el conocimiento teórico, pero también será un apoyo importante para intervenir en los usuarios de dicho centro de salud y mejorar la calidad de vida mediante una adecuada adherencia al tratamiento antihipertensivo.

1.3.2 Justificación Práctica

Desde punto vista práctico este estudio ayudará a analizar y evaluar la situación actual de los pacientes hipertensos e intervenir mediante prevenciones para evitar complicaciones que afecten su salud. Los resultados que se encuentren permitirán sensibilizar al personal de salud, equipo multidisciplinario y principalmente a la comunidad. Además, es necesario que los usuarios conozcan la importancia de la adherencia al tratamiento antihipertensivo, teniendo en cuenta que esta enfermedad cada año va en aumento, y es un gran problema de salud pública, por ello se nos hace importante realizar la investigación en este centro de salud público.

1.3.3 Justificación Metodológica

La presente investigación seguirá el método científico con rigurosidad científica, empleando un enfoque metodológico sólido y herramientas adecuadas para garantizar la validez y confiabilidad de los resultados. Los instrumentos que se utilizaran para este estudio se diseñaron y validaron por 10 jueces expertos del área de la salud.

1.4. Objetivos de la investigación

1.4.1 Objetivo general

Identificar la relación entre el nivel de conocimiento de la Hipertensión arterial y la adherencia al tratamiento antihipertensivo en adultos en un Centro de Salud Público, Lima – 2025.

1.4.2 Objetivos específicos

- Identificar el nivel de conocimiento sobre la Hipertensión arterial en adultos en un Centro de Salud Público, Lima – 2025.
- Identificar el nivel de adherencia al tratamiento antihipertensivo en adultos en un Centro de Salud Público, Lima – 2025.
- Identificar las características sociodemográficas de los pacientes diagnosticados con Hipertensión arterial que asisten al Centro de Salud Público, Lima – 2025.

1.5. Hipótesis

1.5.1 Hipótesis Alterna

Existe una relación significativa entre el nivel de conocimiento y la adherencia al tratamiento antihipertensivo en adultos en un Centro de Salud Público, Lima – 2025.

1.5.2 Hipótesis Nula

No existe una relación significativa entre el nivel de conocimiento y la adherencia al tratamiento antihipertensivo en adultos en un Centro de Salud Público, Lima – 2025.

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes de la investigación

2.1.1 Antecedentes Internacionales

Recalde L. Arguello B, et al. 2022 en Paraguay, publicaron una investigación con el objetivo de determinar “Adherencia al tratamiento y nivel de conocimiento en adultos con hipertensión arterial”. El estudio fue observacional, descriptivo y transversal, incluyó a 425 adultos, mayores de 18 años, con diagnóstico de hipertensión arterial que residían en el barrio de Sajonia entre mayo y octubre de 2022. Los datos se recolectaron mediante entrevistas realizadas casa por casa, y se utilizaron cuestionarios validados (Morisky Green y Batalla) para medir la adherencia al tratamiento y nivel de conocimiento sobre la enfermedad, respectivamente. Los resultados mostraron que solo el 6.1% de los participantes eran mujeres, y que la diabetes mellitus estaba presente en el 28.9% de los casos. En cuanto a la adherencia, se encontró que el 60% de los participantes olvidaba tomar su medicación indicada, el 25% rara vez o nunca la tomaba a la hora indicada, y el 44% discontinuaba al tratamiento debido a los efectos adversos. En relación con el conocimiento, el 7% no creía que la hipertensión arterial fuera una condición permanente, el 9% no creía poder adaptarse a un estilo de vida saludable y solo el 5.8% desconocía los órganos afectados por la enfermedad. Los investigadores concluyeron que la adherencia al tratamiento y el nivel conocimiento sobre la hipertensión arterial eran inadecuados en la población estudiada. (7)

Tirado A. en México en el 2022, realizó una investigación con el objetivo de determinar la “Adherencia terapéutica y nivel de conocimiento de su enfermedad en pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial de la consulta externa en la UMF N°11. El estudio fue observacional, descriptivo y transversal que incluyó pacientes diagnosticados con hipertensión, de diferentes edades y sexos. Se evaluó el cumplimiento terapéutico mediante el Test de Morisky- Green y el nivel de conocimiento con el cuestionario sobre hipertensión. El estudio se realizó en la UMF N°11 de Tapachula, Chiapas, durante el periodo de abril del 2021 a diciembre de 2021 a afiliados al sistema de salud, con la autorización de los pacientes y firma del consentimiento informado. Se realizó un análisis estadístico y los resultados mostraron afluencia de pacientes de sexo femenino. En cuanto al nivel académico, solo el 15,7% había culminado el nivel primario, el 20,3% tiene la secundaria completa, el 18,7% preparatoria, el 23,8% tiene una carrera técnica o está en curso, y el 21,4% una licenciatura. El 5,1% está al pendiente de su medicación prescrita, mientras que el 94,9% no demostró adherencia a las indicaciones médicas. El 55,1% de los pacientes conocía el manejo de su enfermedad, mientras que el 44,9% no tiene el conocimiento adecuado del control de su enfermedad. En conclusión, para logra una adherencia exitosa es necesario un enfoque multidisciplinario, la hipertensión arterial, es una enfermedad no transmisible, se debe a factores que influyen en la adherencia terapéutica, por lo que se deben implementar estrategias para mejorar la adherencia. (8)

Estrada D, Sierra C, Soriano R (2020) realizaron una investigación en España para determinar el “Grado de conocimiento de pacientes hipertensos”. En el estudio multicéntrico descriptivo transversal, realizado en centros de atención primaria y especializada, participaron 980 pacientes hipertensos mayores de 18 años, con

tratamiento farmacológico. Las variables principales incluyeron factores de riesgo, años de diagnóstico, presión arterial, perímetro abdominal, índice corporal. La adherencia a la medicación se evaluó con el Test de Morisky-Green, y el conocimiento con un cuestionario validado, el 50% de los participantes eran mujeres. El 46% tenía el diagnóstico de HTA por más de diez años. La causa más frecuente de incumplimiento era el olvido con el 56,6%. El 42,3% de los usuarios conocía los objetivos de su presión arterial, el 35,8% desconocía que la HTA es permanente, el 41,7% refirió no haber recibido información sobre HTA, y solo el 48,6% conocía las consecuencias de la HTA. Solo el 41,4% de los pacientes sabía que el tratamiento es de por vida. Se Encontraron diferencias significativas entre el nivel de conocimiento y el nivel de estudios ($p < 0,001$), los conocimientos sobre la hipertensión son bajos en la población estudiada. (9)

2.1.2. Antecedentes nacionales

Soplopuc D, Tejeda (2021) realizaron una investigación en Lambayeque con el objetivo de evaluar la “Asociación entre conocimiento sobre hipertensión arterial y adherencia al tratamiento en pacientes hipertensos de un centro de salud”. El estudio, con un diseño descriptivo correlacional de corte transversal, se llevó a cabo en dos centros de salud en la provincia de Chiclayo entre enero y marzo de 2021. La población estuvo conformada por 137 pacientes hipertensos, y se utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia. La adherencia al tratamiento se evaluó con el cuestionario de MBG (Martín-Bayarre-Grau), y el nivel de conocimiento se midió con el cuestionario de CSH. Los resultados mostraron que el 96,5% de los usuarios no tienen un conocimiento adecuado sobre la hipertensión arterial, y la adherencia al tratamiento era parcial. Se encontró una asociación significativa entre nivel de conocimiento inadecuado sobre hipertensión y adherencia parcial al tratamiento (χ^2 6.451; $p = 0.011$; OR 5.147; IC 95% 1.299-20.4). También se encontró asociación significativa entre adherencia parcial, no recibir información sobre hipertensión arterial (χ^2 4.525; $p = 0.033$; OR 4.053; IC 95% 1.026-16.016) y tiempo de consulta menor a 10 minutos (χ^2 4.932; $p = 0.026$; OR 0.887; IC 95% 0.826-0.952). Las demás variables evaluadas no fueron significativas. En conclusión, la falta de conocimiento sobre hipertensión arterial se asocia con una menor adherencia al tratamiento. (10)

Marrufó Gil et al. (2022) realizó un estudio para determinar la “Asociación entre el nivel conocimiento sobre hipertensión arterial y el grado de adherencia al tratamiento en pacientes hipertensos del Hospital De Apoyo I Santiago Apóstol, Bagua Grande – Amazonas, entre los meses mayo y junio. El estudio fue descriptivo correlacional, transversal y prospectivo con un enfoque cualitativo. La población estuvo conformada por 83 pacientes hipertensos. Se utilizó el cuestionario de conocimiento sobre hipertensión (CSH) y el cuestionario para la evaluación de la adherencia terapéutica de Martín, Bayarre - Grau (MBG). El 45,8% de los pacientes tenía un conocimiento adecuado sobre su enfermedad de HTA. Mientras el 54,2% tenía conocimiento inadecuado. Solo del 20,5% de los pacientes tenía una adherencia total al tratamiento, mientras que el 79,5% tenía una adherencia parcial. De los pacientes que cumplían con el tratamiento, el 80,7% indicó que tiene adherencia total y el 19.3% una adherencia parcial. El 43.4% de los pacientes que desconocían sobre la HTA tenían una adherencia del 10,8%. Solo el 36.1% de los pacientes con un buen conocimiento tenían adherencia total. Los pacientes con escaso conocimiento tenían 1.07 veces más probabilidades de

tener una adherencia parcial al tratamiento en comparación con los pacientes con buen conocimiento de la enfermedad. (11)

Villamar M. Sergio M. (2023) realizaron una investigación para determinar “Factores asociados a la adherencia terapéutica en pacientes con hipertensión arterial de la Unidad de Cardiología de Hospital III de Yanahuara, Arequipa. Se realizó un estudio observacional, transversal y prospectivo. La población estuvo conformada por 140 pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial que reciben tratamiento farmacológico. Los instrumentos utilizados fueron una ficha de recolección de datos y la escala de adherencia a la medicación de 8 ítems de Morisky (MMAS-8). Para el análisis estadístico, se utilizaron frecuencias y porcentajes para variables categóricas, media y desviación estándar para variables numéricas, y la prueba de chi cuadrado para la relación entre variables. Los resultados mostraron que el nivel de adherencia terapéutica fue alto en el 20% de los pacientes, medio en el 48,57% y bajo en el 31,43%. Se evidenció que el consumo de remedios naturales se relacionaba con una menor adherencia. Sin embargo, no se encontró relación entre adherencia y factores sociodemográficos ni dudas sobre la enfermedad. En conclusión, se encontró una mediana adherencia al tratamiento antihipertensivo en los pacientes estudiados. (12)

2.1.3 Antecedentes locales

Calle Chaparro et al. (2023) realizaron un estudio de tesis de pregrado con el objetivo de evaluar la asociación entre “Conocimientos, actitudes y adherencia al tratamiento en personas con diagnóstico de hipertensión arterial atendidos en un hospital de Lima”. La población de este estudio fue de 577 pacientes y se realizó mediante vía telefónica entre octubre de 2021 y febrero del 2022. Se realizó un estudio transversal analítico. Se utilizó el Cuestionario sobre Hipertensión (CSH) para medir el conocimiento, el Cuestionario de Capacidad de Autocuidado en el Paciente con Hipertensión Arterial para medir las actitudes y el cuestionario de Martín- Bayarre-Grau (MBG) para evaluar la adherencia. El 59,58% de los participantes eran mujeres, el 68,24% no tiene conocimiento adecuado sobre la HTA, el 67,72% tenía una adherencia parcial, el 16,80% una adherencia total y el 15,49% no tiene adherencia al tratamiento. En conclusión, existe una relación entre el grado de conocimiento, las actitudes y la adherencia al tratamiento de la hipertensión, los pacientes con conocimientos apropiados y un bajo puntaje en actitudes tienen más probabilidades de no tener una buena adherencia al tratamiento. (13)

Rojas Atma, (2023) realizó un estudio de tesis de pregrado con el objetivo de determinar “Conocimiento sobre factores de riesgo y adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes hipertensos del programa adulto mayor del hospital II Ramon, Lima 2022”. Se realizó un estudio observacional, correlacional y transversal, con un enfoque cuantitativo. La población estuvo conformada por 340 pacientes nuevos que ingresan al programa de adultos mayores del hospital. Se calculó una muestra de 181 pacientes. Se utilizaron dos cuestionarios validados por sus autores para medir el conocimiento sobre factores de riesgo y adherencia al tratamiento farmacológico. Los resultados demostraron que el 45,9% tenía un nivel bajo de conocimiento sobre HTA y el 34,3% tenía una adherencia regular al tratamiento. Se concluyó que existe una relación estadísticamente significativa entre el conocimiento sobre los factores de riesgo y la adherencia al tratamiento en pacientes con hipertensión con un valor de $p=0,000 < 0,05$. (14)

2.2. Bases teóricas

Dorothea Orem define al ser humano como un organismo biológico complejo, pensante, racional, con capacidad de analizar su entorno, reflexionar sobre sí mismo y expresar sus sentimientos de manera simbólica. Esta capacidad de acción se manifiesta a través del concepto de “agencia de autocuidado”, el cual, se caracteriza por la facultad que tiene el individuo para realizar acciones necesarias para conservar o mejorar su bienestar.

La teoría de Orem se enfoca en la identificación de los requisitos de autocuidado, se consideran como las acciones que una persona realiza de forma consciente para mantener y mejorar su salud y bienestar. Orem identifica tres tipos de teoría que se relacionan entre sí: teoría de autocuidado que identifica las acciones que realiza una persona para mantener su salud; la teoría del déficit del autocuidado que describe las causas de la incapacidad para realizar estas acciones; y la teoría de los sistemas de enfermería, la cual analiza cómo la enfermera puede ayudar mediante la orientación, el apoyo emocional y la educación para la salud a superar el déficit. Los componentes de poder de la persona son la atención, razonamiento, toma de decisiones, capacidad de ordenar y realizar sus acciones para su autocuidado en la vida diaria. Los factores condicionantes básicos comprenden componentes como los recursos disponibles, la edad, el nivel educativo, la cultura, el género y las condiciones del estado de salud. Son requisitos básicos que varían según la etapa de desarrollo y necesidades y que son compartidos por todas las personas, sin importar su edad, género u origen cultural.

Orem también presenta tres sistemas de enfermería, el sistema totalmente compensatorio, el sistema parcialmente compensatorio y el sistema de apoyo educativo. Por ende, el profesional de enfermería, al conocer estos sistemas prioriza los factores de poder de la persona, comunidad o grupo. Este avance identifica los conceptos y la evidencia de la interrelación entre los mismos, dicho modelo se aplica en diferentes situaciones en la atención de enfermería. Orem también refiere que la enfermería es una “ciencia práctica.” (15)

En cuanto al manejo de la hipertensión, el autocuidado implica adoptar hábitos saludables como una alimentación equilibrada, actividad física regularmente, el cumplimiento de la medicación prescrita y monitoreo constante de la presión arterial. Sin embargo, la falta de información sobre la enfermedad, las dificultades para seguir las indicaciones médicas o la ausencia de apoyo pueden generar un déficit de autocuidado, lo que a su vez puede comprometer la adherencia al tratamiento.

2.3 Marco conceptual

La hipertensión arterial representa un factor de riesgo principal para el desarrollo de diversas afecciones graves, tales como enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares y enfermedades renales, lo que la convierte en un problema de salud pública significativo a nivel mundial. La presión arterial se define como la fuerza ejercida por el flujo sanguíneo contra las paredes de las arterias, y se representa numéricamente mediante dos valores fundamentales: la presión sistólica y la presión diastólica. En primer lugar, la presión sistólica corresponde a la fuerza que la sangre ejerce sobre las arterias cuando el corazón se contrae y bombea sangre al resto del cuerpo. Por otro lado, la presión diastólica, que es el valor más bajo, refleja la presión arterial cuando el corazón se encuentra en reposo entre los latidos, permitiendo que se llene de sangre para el siguiente ciclo. Ambos valores son esenciales para evaluar de manera precisa el estado de la salud cardiovascular, ya que son indicadores clave para el diagnóstico de la hipertensión. Si no se controla adecuadamente, la hipertensión puede aumentar

significativamente el riesgo de complicaciones graves para la salud, como las ya mencionadas. (16)

La Asociación Americana del Corazón refiere que la presión normal está por debajo de los valores de 120/80mmHg, si la presión sistólica varía entre 120 y 129 y la presión diastólica es menor a 80 significa que es una presión arterial elevada, sin embargo, si los valores son mayores a 130 en la sistólica y la diastólica es de 80 o superior y se mantiene alta con el tiempo significa que es una presión arterial alta. La hipertensión se clasifica en dos etapas según gravedad de la elevación de la presión arterial, siendo este un factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares y renales. (17)

La hipertensión arterial, reconocida como una condición médica de cuidado desde hace medio siglo, no siempre fue considerada una enfermedad. El descubrimiento de la presión sanguínea se le atribuye a Stephen Hales, quién en 1799 inventó y utilizó el manómetro de mercurio para medirla. En 1847, Carl Ludwig, basándose en los trabajos de Poiseuille, desarrolló el quimógrafo, método gráfico para registrar datos clínicos. Este avance fue muy útil para la investigación en fisiología. Durante años, muchos investigadores buscaron métodos no invasivos para medir la presión arterial. En 1856, Faivre realiza la primera medición de la presión, registrando cifras de 120 mm Hg en la arteria femoral y 115-120 mm Hg en la braquial. Sin embargo, esta técnica no fue aceptada porque requería puncionar la arteria. (18)

En 1896, Riva-Rocci presentó el método en el que se basa la técnica de medición actual. Su investigación fue muy importante para que, en el siglo XX, se mejorara la medición de la presión y se definieran con claridad los valores de la presión sistólica y diastólica, incluyéndose en los exámenes médicos de rutina. Una vez que se identificó la hipertensión como un problema de salud importante, se reconoció como una enfermedad y se comenzó a tratar. Finalmente, en el estudio SPRINT, realizado en el 2015, se demostró que reducir la presión arterial sistólica en personas no diabéticas, disminuye la enfermedad y la mortalidad en pacientes con hipertensión. (18)

Definición de conocimiento

El conocimiento es la mejor manera de aproximarse a la realidad gracias a la aprehensión consiente del sentido y el significado que se le da a la información recibida. Desde esta perspectiva, el conocimiento se concibe como la asimilación racional del conjunto de información y de conceptos abstractos, obtenidos mediante la observación, el estudio y la experiencia. Una herramienta esencial para comprender la naturaleza y de todo lo que existe, y sus interconexiones y características a través del razonamiento. Desde esta perspectiva, el conocimiento se concibe como un conjunto de información y conceptos abstractos que se obtienen mediante la observación y la experiencia. (19)

A lo largo de la historia, el concepto de conocimiento ha evolucionado significativamente, influenciado por las atribuciones de numerosos pensadores y el avance de diversas disciplinas como la filosofía, la psicología y las ciencias sociales.

“Según Platón, es el conocimiento una participación en la Ideas, las que concebía como los seres reales, y exactamente como tanto el desarrollo de los seres sensibles cuanto la posibilidad de conocerlos depende del Sol, fuente a la vez del calor con que se desarrollan y de la luz en que se los ve, también el Ser y el conocimiento se derivan

ambos de un principio común- un Sol inteligible, por decirlo así” (Policarpo, 2017). Aristóteles, por su parte, “afirma que el hombre conoce por medio de sus sentidos, es decir, todo conocimiento comienza en los sentidos; mediante ellos, el hombre, toma contacto con las cosas, no obstante, el conocimiento de cosas particulares debe llegar a su grado máximo que es el conocimiento contemplativo o teórico (Policarpo, 2017). Es por su importancia e interés que el conocimiento en si mismo es un objetivo científico: la epistemología es la rama de la filosofía que estudia los principios y métodos del conocimiento, pues este es el punto de partida de toda investigación científica, y su búsqueda implica el uso de procesos sistemáticos para dar respuesta a problemáticas existentes.

“La fuente principal de nuestra ignorancia es el hecho de que nuestro conocimiento sólo puede ser finito, mientras que la ignorancia es necesariamente infinita” (Popper, 1972) El conocimiento es el punto de partida de toda investigación científica, y su búsqueda implica el uso de procesos sistemáticos para dar respuestas a problemáticas existentes. La epistemología, rama de la filosofía, estudia los principios y métodos del conocimiento. Según Ramírez (2009), el conocimiento es el acto consciente e intencional para aprender las cualidades del objeto. Muchos filósofos como Aristóteles, Platón y otros han hecho aportes significativos sobre la definición de conocimiento, destacando su relación con la experiencia y la realidad. El conocimiento puede ser organizado y sistemático, lo que lo convierte en conocimiento científico.

En la actualidad, el conocimiento es considerado un elemento fundamental, en un entorno complejo y cambiante. Según Popper (1972) “la fuente principal de nuestra ignorancia es el hecho que nuestro conocimiento solo puede ser finito, mientras que la ignorancia es necesariamente infinita”; mientras que Ramírez (2009) destaca que el conocimiento es el acto consiente e intencional para aprender las cualidades del objeto. En resumen, el conocimiento es un proceso dinámico que implica la adquisición y organización de información mediante la experiencia y la razón para la comprensión del mundo. (20, 36)

Características

Los estudios de Nieto y Rodríguez (2010) y Pérez, Galán y Quintanal (2012) destacan varias características fundamentales del conocimiento científico que definen su naturaleza. Estas características son:

Racional: surge de una actividad humana exclusiva de la razón.

Objetivo: busca la verdad objetiva y un conocimiento fiel a la realidad.

Intelectual: se fundamenta en procesos lógicos basados en la sensación, percepción y representación.

Universal: es aplicable en cualquier contexto y para todas las personas.

Verificable: Todo conocimiento puede ser sometido a verificación.

Sistemático: se organiza de manera estructurada y coherente.

Preciso: se orienta a la exactitud para evitar confusiones.

Seguro: someterse a procesos de verificación, garantiza un alto grado de fiabilidad en su aplicación. (21)

Niveles de conocimientos

Conocimiento empírico: se basa en la experiencia cotidiana y el sentido común obteniendo información a través de la observación directa y las experiencias personales. Este tipo de conocimiento se desarrolla de manera informal, sin una metodología estructurada, y es comúnmente utilizado para abordar situaciones prácticas y cotidianas. (21)

Conocimiento científico: se fundamenta en la comprensión y explicación de la realidad a través de una investigación sistematizada y metodológica, empleando el método científico como herramienta principal. Este tipo de conocimiento busca obtener resultados verificables y reproducibles mediante un proceso riguroso de análisis y experimentación. (21)

Conocimiento filosófico: se enfoca en la reflexión profunda sobre los problemas fundamentales de la existencia y el conocimiento. Este tipo de conocimiento utiliza un enfoque crítico y analítico, cuestionando las bases de la realidad y la percepción humana, para entender de manera conceptual y teórica los fenómenos que nos rodean. (21)

Según Curihuaman del Pino (2021), quien se basó en el trabajo del Dr. Wilfredo Huertas Bazalar, distingue tres niveles de conocimientos, basados en la capacidad cognoscitiva del individuo y su relación con la realidad, están compuestos por:

Nivel bueno: (óptimo) el individuo posee una capacidad cognoscitiva sobresaliente, estableciendo una conexión lógica y coherente entre su pensamiento y la definición del objeto de estudio. Este nivel se caracteriza por la facultad de comprender, deducir y discernir lo que le rodea. (22)

Nivel medio: (medianamente logrado) el individuo demuestra un entendimiento parcial del objeto de estudio. Su conocimiento puede ser limitado debido a factores como el intelecto en desarrollo o una instrucción incompleta. En este nivel, el individuo puede desconocer ciertos aspectos del tema en cuestión. (22)

Nivel bajo: (pésimo) el individuo experimenta dificultades para comprender y relacionarse con el objeto de estudio. Su capacidad cognoscitiva es insuficiente para establecer conexiones lógicas, lo que se refleja en sus expresiones incoherentes. Este nivel se caracteriza por un conocimiento restringido y una comprensión superficial. (22)

El Conocimiento en Enfermería

La toma de decisiones en la práctica de enfermería contemporánea se fundamenta en la integración de conocimientos científicos provenientes de diversas disciplinas, incluyendo ciencias naturales, sociales, de la conducta y humanidades. Esta integración de conocimientos permite a las enfermeras actuar de manera informada, priorizando las necesidades de los pacientes y brindando cuidados personalizados. La práctica basada

en la evidencia implica la búsqueda, evaluación y aplicación de evidencia científica en la toma de decisiones. Las enfermeras, en colaboración con los pacientes, utilizan su juicio clínico, consideran los valores y preferencias individuales, y establecen prioridades para promover una relación terapéutica. La complejidad de la atención de enfermería requiere que las profesionales manejen múltiples prioridades y colaboraren eficazmente con otros miembros del equipo de salud. (23)

El Sistema cardiovascular

El sistema cardiovascular es una red compleja que juega un papel fundamental en nuestra supervivencia. Su función principal es transportar sangre rica en oxígeno a todas las células del cuerpo, proporcionándole el oxígeno y los nutrientes necesarios para funcionar correctamente. Al mismo tiempo, transporta los productos de desechos que del metabolismo celular. (24, 25)

Este sistema está formado por:

El corazón: una potente bomba muscular que impulsa la circulación sanguínea.

Las arterias: vasos sanguíneos distribuyen la sangre desde el corazón hacia los tejidos.

Las venas: vasos sanguíneos que devuelven la sangre al corazón.

Los capilares: son los vasos microscópicos donde se produce el intercambio de sustancias entre la sangre y las células.

El corazón: anatomía y función

El corazón es un órgano muscular que se encuentra en el lado izquierdo del tórax y pesa aproximadamente entre 250 – 300 gramos en adultos, similar al tamaño de un puño. Este órgano tiene su propio sistema de conducción eléctrica que controla la frecuencia y el ritmo de los latidos. Este sistema está compuesto por células específicas que generan impulsos eléctricos y los propagan a través del miocardio, controlando la contracción de las diferentes cámaras cardíacas. (24, 25)

Sus partes principales son:

Pericardio: membrana que rodea el corazón y lo mantiene en su posición.

Capas del corazón:

Epicardio: capa externa

Miocardio: tejido muscular cardíaco

Endocardio: capa interna que recubre el corazón y las válvulas.

Las cavidades son:

Aurícula derecha: cavidad delgada recibe la sangre de las venas cavas superior e inferior.

Ventrículo derecho: cavidad de paredes gruesas bombea sangre hacia los pulmones.

Aurícula izquierda: cavidad delgada recibe sangre oxigenada de los pulmones.

Ventrículo izquierdo: cavidad de paredes gruesas bombea la sangre a todo el cuerpo.

Las válvulas cardiacas: mitral, tricúspide, aórtica y pulmonar, que aseguran que la sangre fluya en una sola dirección a través del corazón.

La sangre: un tejido vital

La sangre es un tejido conectivo líquido que conecta y comunica a los diferentes tejidos del cuerpo, cumpliendo múltiples funciones esenciales, entre ellas son: distribuir nutrientes, intercambiar gases, transportar desechos celulares y proteger contra microorganismo y hemorragias. La sangre está compuesta por cuatro elementos: plasma, glóbulos rojos, leucocitos y plaquetas. (24,25)

El ciclo cardiovascular: un proceso continuo

El sistema cardiovascular es un proceso continuo de contracción y relajación. La sangre desoxigenada regresa al corazón y es bombeada hacia los pulmones donde se oxigena y libera el dióxido de carbono. Luego, la sangre oxigenada regresa al corazón y es bombeada hacia todo el cuerpo, donde libera el oxígeno y recoge el dióxido de carbono. Este ciclo se repite una y otra vez para mantener el oxígeno y los nutrientes adecuados para el buen funcionamiento de las células.

El ciclo cardíaco se divide en dos fases principales:

Sístole: es la fase de contracción del músculo cardíaco(miocardio). Los ventrículos se contraen y expulsan sangre hacia las arterias aorta (desde el ventrículo izquierdo) y pulmonar (desde el ventrículo derecho). Mientras esto ocurre, las aurículas se relajan y comienzan a llenarse de nuevo con sangre proveniente de las venas.

Diástole: es la fase de la relajación del miocardio. Durante esta fase, los ventrículos se relajan y se llenan de sangre que proviene de las aurículas, que a su vez se contraen para impulsar más sangre hacia los ventrículos. (24, 25)

El gasto cardíaco: es la cantidad de sangre que el corazón expulsa por minuto y depende directamente de eficiencia de la sístole y diástole, se llena para prepararse para siguiente contracción. Un equilibrio adecuado entre estas fases asegura un gasto cardíaco óptimo. (24, 25)

Precarga: es la presión que ejercida sobre las paredes del ventrículo al final de la diástole, cuando está lleno de sangre. Está relacionada con la cantidad de sangre que regresa al corazón.

Poscarga: es la resistencia que el ventrículo izquierdo debe superar para expulsar la sangre hacia la aorta durante la sístole. Está relacionada con la presión arterial diastólica, que es la presión mínima necesaria para abrir la válvula aortica. (24, 25)

La presión arterial

Es un parámetro clínico fundamental, ya que refleja el estado del sistema vascular tanto en situaciones agudas como crónicas. Cuando su paciente presenta valores elevados de presión arterial en dos o más consultas médicas, es posible que el profesional de salud le diagnostique hipertensión. Por otro lado, los ruidos cardíacos S1 y S2 son sonidos normales que se perciben durante la auscultación del corazón. El sonido S1 ocurre cuando se cierran las válvulas mitral y tricúspide, marcando el inicio de la sístole. Posteriormente, se escucha S2, que corresponde al cierre de las válvulas aórtica y pulmonar, indicando el comienzo de la diástole. La identificación de estos sonidos normales es crucial, ya que la presencia de ruidos anormales, como S3, S4 o soplos, puede ser indicativo de alguna patología cardíaca. (25)

La regulación de la presión arterial

La regulación de la presión se divide en mecanismos agudos y crónico. Los mecanismos agudos corrigen desequilibrios temporales, como los causados por el ejercicio físico o cambios de posición, a través de los barorreceptores. Estos receptores, ubicados en las arterias carótidas y el arco aórtico, detectan cambios de presión y envían señales al sistema nervioso central para ajustar la resistencia vascular periférica y el gasto cardíaco. Por otro lado, la regulación a largo plazo depende principalmente de los riñones y el sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA). Este sistema regula el volumen sanguíneo y la presión arterial mediante la reabsorción de sodio y agua, la vasoconstricción y la liberación de hormonas como la aldosterona y la hormona antidiurética (ADH). La ADH, producida en el hipotálamo, aumenta la reabsorción de agua e los riñones, lo que eleva el volumen plasmático y la presión arterial. además, la presión arterial sigue un patrón circadiano, siendo más elevada por las mañanas y disminuyendo gradualmente durante el día y la noche. Estos mecanismos, tanto agudos como crónicos, trabajan en conjunto para mantener la estabilidad del sistema cardiovascular. (26, 27)

La Hipertensión Arterial

La hipertensión arterial (HTA) es una enfermedad muy frecuente y uno de los principales factores de riesgo cardiovascular. Se define como la fuerza excesiva que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias, generada por el bombeo del corazón. Cuanto más elevada sea la presión arterial, mayor será el esfuerzo que el corazón debe realizar para bombear la sangre, lo que puede causar daños irreparables en órganos como el corazón, el cerebro, los riñones y los ojos. (27, 28)

La enfermedad hipertensiva es un padecimiento vascular, arterial, sistémico, inflamatorio, crónico y progresivo. Partiendo de este concepto genérico, se desprende que el vaso sanguíneo es el órgano primario de afección, y dentro de esta estructura está el endotelio. Este órgano es vital en la homeostasis vascular, ya que de su normal funcionamiento depende el equilibrio y, por ende, la edad, la salud integral vascular. Es importante señalar que, además de diversos factores como la herencia y el estilo de vida, un sistema nervioso simpático hiperactivo, la ingesta excesiva de sal y las hormonas o sustancias liberadas por el endotelio enfermo puede modificar el gasto cardíaco o la resistencia vascular periférica, lo que inicia la enfermedad. (27, 28)

La HTA no solo causa daño en las arterias y el corazón, sino que también genera un ciclo de riesgo que aumenta la probabilidad de complicaciones cardiovasculares. La fricción y la presión elevada dañan las paredes arteriales, lo que facilita el depósito de lípidos y la formación de placas de aterosclerosis, lo que a su vez eleva aún más la presión arterial y agrava el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Además, la HTA es un factor de riesgo significativo para enfermedades cardiovasculares, y su incidencia es mayor en personas hipertensas que en aquellas con presión arterial normal. La presencia de HTA también se asocia con un mayor riesgo de complicaciones en personas que padecen otras enfermedades, como diabetes, tabaquismo, dislipemia, obesidad y un estilo de vida sedentario. Es importante destacar que la HTA aumenta entre 2 y 4 veces la frecuencia de complicaciones relacionadas con la aterosclerosis. La hipertensión arterial representa un desafío significativo para la salud pública, ya que se presenta como una amenaza silenciosa que afecta a gran parte de la población, poniendo en riesgo su bienestar y calidad de vida. Si no se diagnostica y trata oportunamente, puede tener consecuencias graves y potencialmente mortales. (27, 28)

Clasificación de la Hipertensión Arterial

La hipertensión arterial se clasifica en diferentes categorías según la guía técnica nacional, que se basa en los siguientes rangos de presión arterial:

Normal: presión arterial sistólica (PAS) ≤ 120 mmHg y presión arterial diastólica (PAD) ≤ 80 mmHg.

Pre- hipertensión: PAS entre 120-139 mmHg y PAD entre 80- 89 mmHg.

Estadio 1: PAS entre 140 a 159mmHg y PAD entre 90 a 99mmHg.

Estadio 2: PAS ≥ 160 mmHg y PAD ≥ 100 mmHg.

Factores de riesgo

Existen factores de cardiovasculares que aumentan las probabilidades de desarrollar enfermedades cardíacas y de los vasos sanguíneos, estos factores se dividen en dos categorías:

Factores de riesgo no modificables: son aquellos aspectos inherentes al individuo que no se puede modificar, como:

- Los antecedentes familiares
- El sexo
- La edad

Factores de riesgo modificables: son aquellas que se pueden prevenirse o controlarse mediante cambios de estilo de vida o tratamiento médico como:

- Padecer diabetes
- Sedentarismo
- Tabaquismo
- Depresión y/o estrés
- Obesidad
- Dislipidemias
- Factores trombotogénicos
- Hipertrofia ventricular izquierda
- Triglicéridos elevados

Signos y síntomas

El 70 % a 80 % de los casos, la hipertensión arterial (HTA) se presentan de forma asintomática. Sin embargo, cuando los síntomas aparecen, pueden incluir:

- Tinnitus (zumbidos en los oídos).
- Mareos
- Cefalea
- Escotomas (puntos ciegos en el campo visual) o epistaxis (sangrado nasal).

Otros síntomas que puede presentar son fatiga, disnea (dificultad para respirar) al menor esfuerzo y sensación de inestabilidad.

Prevención de la Hipertensión arterial

La HTA puede controlarse mediante acciones preventivas, como:

- Disminución y gestionar adecuadamente la carga emocional.
- Cumplir con los controles médicos indicados por el especialista.
- Iniciar un tratamiento oportuno una vez diagnosticada la enfermedad.

Además de lo mencionado, es fundamental adoptar otras medidas para controlar la presión arterial, entre ellas:

- Mejorar el estilo de vida.
- Mantener un peso adecuado.
- Seguir una dieta equilibrada.
- Realizar actividad física de acorde con la edad, como mínimo 30 minutos diarios.
- Evitar el consumo de alcohol
- Reducir o abandonar los hábitos de fumar. (29, 31)

Adherencia al tratamiento

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (2003) la adherencia al tratamiento de enfermedades crónicas es un gran desafío global, presentando un 50% en países desarrollados. En el caso de la adherencia al tratamiento para hipertensión arterial varía de manera considerable pues solo alcanzó las cifras de 27% en Gambia, 43%, en China y 51% en Estados Unidos. Estos datos nos hacen ver la necesidad de implementar estrategias que tengan efectividad para mejorar la adherencia al tratamiento y garantizar una mejor calidad de vida. (32)

El Dr. Soto Javier, del departamento de Farmacoeconomía de Pfizer, indica que la mala adherencia al tratamiento es responsable de ingresos hospitalarios de al menos del 5 y 10%, de 2,5 millones de urgencias médicas y 125.00 de muertes solo en Estados Unidos.

La adherencia se determina como el grado cumplimiento y constancia que son fundamentales para mejorar la salud de los pacientes, por lo tanto, se comprende el seguir las indicaciones prescritas por el profesional de la salud, entre los cuales debe cumplir con la dosis, horario indicado, llevar un control de manera regular y cumplir con la indicación durante el tiempo que se le indique. Es por ello por lo que la relación entre el profesional de la salud y la paciente debe existir confianza mutua, respeto y comunicación adecuada y empática permitiendo que el paciente se sienta cómodo a la

hora de compartir su información personal y el médico tratante debe brindar información clara y concisa sobre el diagnóstico, tratamiento y sus objetivos respetando sus creencias y valores del paciente.

Sin embargo, la falta de adherencia al tratamiento se clasifica en 2 categorías:

Adherencia Primaria: es cuando la receta o indicación prescrita no se retira de la farmacia.

Adherencia Secundaria: puede ser ocasionada por diferentes factores que alteran el régimen terapéutico prescrito por el médico tratante y estas pueden ser:

- Modificación de dosis correcta
- Cambios en la dosificación
- Olvido en la administración del fármaco
- Aumento en la frecuencia de la dosis
- Suspensión del tratamiento antes del tiempo indicado

Por otro lado, la Dra. Pastor, Ana vicepresidenta de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria nos indica que la falta de comprensión al tratamiento se debe a varios factores de los cuales son:

- Problemas con el régimen prescrito (efectos adversos)
- Instrucciones deficientes
- Mala relación médico- paciente
- Desacuerdo del paciente respecto al tratamiento indicado
- Mala memoria u olvido de la toma de los medicamentos

De igual forma también se refiere que la “comunicación” es fundamental y en la atención primaria es esencial ya que, al no contar con la tecnología adecuada, es el primer contacto con el usuario con el sistema sanitario, siendo la comunicación un elemento clave en el proceso de diagnóstico y tratamiento. Entre los aspectos más importantes son:

- Dar a conocer las consideraciones sobre el proceso.
- Hacer sugerencias mejor que preinscripciones.
- Facilitar que los pacientes expresen libremente sus ideas y opiniones (preocupaciones y creencias).
- Lograr un entendimiento mutuo.
- Ofrecer alternativas
- Asegurarse que el paciente esté de acuerdo con lo indicado.

Apoyo familiar y su relación con adherencia.

En el tratamiento de la hipertensión arterial, el apoyo familiar cumple un papel importante. No solo depende del compromiso del adulto seguir su tratamiento, sino también del acompañamiento que recibe en casa, la familia muchas veces ayuda recordando la toma de los medicamentos, acompañando a los controles médicos y animando a mantener una alimentación saludable.

Cuando el adulto siente el apoyo, se incentiva el seguimiento de las indicaciones del profesional de salud y cuidar de su presión arterial. En cambio, cuando no tiene puede olvidar la dosis o dejar de acudir a sus controles. (37)

La Organización Mundial de la Salud (2003) menciona que la adherencia a los tratamientos no depende únicamente del paciente, sino también de factores familiares y sociales que pueden favorecer o dificultar el cumplimiento. De igual manera, en una investigación realizada por Cueva (2020) en un hospital público de Lima, se encontró que las personas con hipertensión que contaban con apoyo familiar mostraban mejores niveles de adherencia en comparación con quienes no lo tenían.

Por esa razón, en este estudio se considera el apoyo familiar como una parte importante dentro de la adherencia al tratamiento antihipertensivo, ya que puede influir positivamente en el control de la enfermedad y en la calidad de vida del adulto.

En conclusión, la adherencia al tratamiento antihipertensivo es un elemento esencial para prevenir y controlar la Hipertensión Arterial, de esta forma prevenimos las complicaciones cardiovasculares. Los factores que influyen en la adherencia, combinando con las estrategias efectivas para optimizar los resultados salud y así mejorar la calidad de vida de los pacientes que padecen esta enfermedad, siendo también fundamental que los profesionales de la salud, los pacientes y el resto de equipo multidisciplinario trabajen juntos para abordar los desafíos de la adherencia y garantizando un manejo positivo de la hipertensión. (33, 34)

CAPÍTULO III. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1 Tipo de estudio y diseño de la investigación

El presente estudio tiene un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo correlacional con un diseño no experimental y de corte transversal, ya que se buscará determinar la relación entre nivel de conocimiento y la adherencia al tratamiento antihipertensivo en un solo momento, sin manipular variables. Este diseño permitirá analizar los datos de manera objetiva, describiendo las características de los participantes y la relación existente entre ambas variables.

3.2 Población y muestra

La población del presente estudio estará conformada por 150 adultos diagnosticados con hipertensión arterial, registrados en el padrón nominal del Centro de Salud Materno Infantil de Surquillo, Lima - 2025.

3.2.1 Tamaño de la muestra

El tamaño de la muestra será de tipo probabilístico, muestreo aleatorio simple.

3.2.2 Selección de muestreo

La muestra será seleccionada mediante un muestreo probabilístico, de tipo aleatorio simple, en el cual todos los pacientes con hipertensión arterial tienen la probabilidad de ser seleccionados.

3.3 Criterios de inclusión y exclusión

Criterios de inclusión:

- Pacientes diagnosticados con hipertensión arterial que acuden al servicio de medicina del Centro de Salud Publico, Lima -2025.

- Adultos a partir de los 18 años de ambos sexos que reciben tratamiento antihipertensivo del Centro de Salud Público, Lima -2025.
- Adultos a partir de los 18 años, que deseen participar de la investigación y firmen el consentimiento informado del Centro de Salud Público, Lima -2025.
- Adultos que residan en la zona geográfica definida para la investigación.

Criterios de exclusión:

- Adultos con hipertensión arterial que no deseen participar de la investigación y no firmen el consentimiento informado.
- Pacientes con trastornos cognitivos que dificulten la comprensión del cuestionario.
- Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, debido a las variaciones fisiológicas de la presión arterial.

3.4 Variables

3.4.1 Definición conceptual y operacionalización de variables

Variable 1: Nivel de conocimiento sobre la hipertensión arterial.

Definición Conceptual

El conocimiento es una habilidad fundamental que facilita la comprensión de la naturaleza de los fenómenos que nos rodean. En el contexto de la salud, esta capacidad resulta crucial para que los pacientes puedan acceder a la información sobre condiciones médicas, como la hipertensión arterial. La comprensión de la enfermedad permitirá evaluar y analizar las respuestas de los pacientes, las cuales estarán directamente relacionadas con el nivel de conocimiento que poseen sobre su condición de salud. (21)

Definición Operacional

La información que cada individuo posee acerca de la hipertensión arterial será evaluada mediante un cuestionario compuesto por 13 preguntas. A cada respuesta correcta se le asignará un valor de un punto, mientras que las respuestas incorrectas recibirán un puntaje de cero. El puntaje obtenido permitirá clasificar el nivel de conocimiento en tres categorías: Alto, medio y bajo, según los rangos establecidos a continuación: (10, 24).

Nivel de conocimiento alto: de 9 a 13 puntos

Nivel de conocimiento medio: de 5 a 8 puntos

Nivel de conocimiento bajo: de 0 a 4 puntos

Este enfoque facilitará la medición objetiva del grado de comprensión que los participantes tienen sobre la hipertensión arterial, permitiendo una evaluación precisa de su conocimiento sobre la enfermedad.

Variable 2: Adherencia al tratamiento antihipertensivo.

Definición Conceptual

La adherencia se determinará como el grado en el que el paciente cumpla de manera constante y adecuada con las indicaciones del médico tratante y el de enfermería relacionada con el tratamiento farmacológico. Este cumplimiento incluirá el seguimiento de la toma de medicamentos en dosis, horarios establecidos, el control regular de la presión y la asistencia regular a las consultas programadas por el profesional de la salud y la mejora de sus hábitos saludables y autocuidado.

Así mismo, se reconoce el apoyo familiar como un factor determinante en la adherencia, ya que el acompañamiento emocional, la supervisión y el recordatorio constante por parte de un familiar cercano influye positivamente en el cumplimiento terapéutico y en la motivación de paciente. (29, 30)

Definición operacional

La adherencia al tratamiento antihipertensivo, se evaluará mediante un cuestionario compuesto de 13 preguntas, cada una con dos alternativas. Para su categorización, las respuestas se clasificarán en dos opciones: “Sí” o “No”, lo que permitirá determinar si el paciente se adhiere o no al tratamiento. Según lo establecido a continuación: (29, 30)

Se adhiere (13)

No se adhiere (< 13)

Este concepto de adherencia se asume implícitamente como un factor crucial, dado su impacto directo en el estado de salud de los pacientes.

Factores sociodemográficos y socioeconómicos

Definición conceptual

- **Edad:** la edad es una variable cuantitativa continua que mide el tiempo transcurrido desde el nacimiento de un individuo hasta el momento de la observación. Es una variable numérica que puede tomar cualquier valor dentro de un rango específico, sin intervalos discretos.
- **Tiempo de enfermedad:** es una variable cuantitativa continua que representa la duración de la enfermedad desde el diagnóstico. Aunque es continua puede clasificarse en categorías nominales.
- **Sexo:** es una variable cualitativa dicotómica nominal que clasifica a los individuos en dos categorías: masculino y femenino. Las categorías son mutuamente excluyentes y no tiene un orden jerárquico entre ellas.
- **Residencia:** es una variable Cualitativa politómica nominal que clasifica a los individuos según el tipo de lugar donde viven, como urbano, rural, etc. las categorías son distintas entre sí, pero no existe un orden jerárquico entre ellas.
- **Raza:** es una variable cualitativa que clasifica a los individuos según características físicas o sociales, como caucásico, afrodescendiente, asiático, entre otras. Esta variable es politómica porque tiene más de dos categorías, y – nominal porque no hay un orden jerárquico entre categorías.

- **Formación académica:** es una variable cualitativa que clasifica a los individuos según el nivel educativo alcanzado, como primaria, secundaria, bachillerato, universidad, etc. es politómica porque tiene más de dos categorías ordinal porque las categorías tienen un orden jerárquico o secuencial, indicando un nivel creciente de educación.
- **Estado civil:** es una variable cualitativa que clasifica a los individuos según su situación marital, como soltero, casado, divorciado, viudo, etc. Es politómica, ya que tiene más de dos categorías, y nominal, porque no existe un orden jerárquico entre las opciones.
- **¿Sus padres tienen o tuvieron Hipertensión?** Esta variable es cualitativa – dicotómica – nominal, pues se refiere a dos posibles respuestas: sí o no. La variable clasifica a los participantes en dos categorías, sin que haya un orden jerárquico entre ellas.
- **Situación laboral:** es una variable cualitativa que clasifica a los individuos según su estatus en el ámbito laboral, como empleado, desempleado, jubilado, estudiante, entre otros. Al ser politómica, tiene más de dos categorías, y al ser nominal, las categorías no tienen un orden jerárquico intrínseco.
- **Régimen de salud:** es una variable cualitativa que clasifica a los individuos según su tipo de cobertura sanitaria, como seguro público, privado, o ninguna cobertura. Es politómica, ya que tiene más de dos categorías, y nominal, pues las categorías no tienen un orden jerárquico.

3.5 Plan de recolección de datos e instrumentos

Variables principales 1: Nivel de conocimiento sobre hipertensión arterial.

Instrumento

Para la recolección de los datos, se empleará la técnica de la encuesta, utilizando como instrumento un cuestionario auto- dirigido que evaluará el nivel de conocimiento sobre la hipertensión arterial. El cuestionario consta de 13 ítems, cada uno con 4 alternativas de respuesta, de las cuales solo una será la correcta. Las respuestas serán categorizadas mediante una escala politómica ordinal, definida en tres niveles: bajo (0-4), medio (5-8) y alto (9-13) (Ver anexo 1B).

Este instrumento fue elaborado por las autoras de la investigación, y para garantizar su validez, fue sometido a la evaluación de 10 jueces expertos del área de la salud. Los expertos emitieron un juicio de valor sobre la pertinencia y claridad de los ítems del cuestionario, asegurando así la adecuación del instrumento para medir el conocimiento sobre la hipertensión arterial. (21, 22, 24)

Validez

El cuestionario fue validado por un total de 10 jueces expertos en el campo de la salud. Para evaluar la validez del instrumento, se utilizó el coeficiente V de Aiken obteniendo un valor de 0.95 con un nivel de significancia $P < 0.05$. Este resultado demuestra que el instrumento presenta un alto grado de validez, lo que garantiza su capacidad para medir de manera adecuada el conocimiento sobre la hipertensión arterial. (Ver anexo 5)

Variables principales 2: adherencia al tratamiento antihipertensivo

Instrumento

Para la recolección de datos usaremos la técnica de la encuesta, utilizando como instrumento un cuestionario auto- dirigido diseñado para evaluar la adherencia al tratamiento antihipertensivo. El cuestionario constará de 13 ítems, cada uno con 2 alternativas de respuesta, las cuales reflejan dos opciones: una que indica adherencia al tratamiento (respuesta positiva) y otra que indica falta de adherencia (respuesta negativa). Las respuestas se medirán mediante una categoría dicotómica nominal. (Ver anexo 1C).

Este instrumento fue desarrollado por las autoras de investigación y sometido al juicio de valor de 10 jueces expertos en el área de la salud, con el fin de garantizar su pertinencia y validez (29,30).

Validez

El cuestionario fue validado por un total de 10 jueces expertos en el campo de la salud (Ver anexo 5). Para analizar los resultados de la validez del instrumento, se aplicó la prueba del coeficiente V de Aiken, obteniéndose un valor de 0.95, con un nivel de significancia de $P < 0,05$. Este resultado indica que el instrumento posee un alto grado de validez, lo cual asegura su capacidad para medir adecuadamente la adherencia al tratamiento antihipertensivo. (Ver anexo 5)

Factores sociodemográficos y socioeconómicos:

Para la recolección de datos en esta investigación, se utilizarán dos instrumentos. el primero consiste en una ficha que recoge los datos sociodemográficos y socioeconómicos de los participantes, seguida de un cuestionario auto – que evalúe el nivel de conocimiento sobre la hipertensión arterial. Este cuestionario consta de 13 ítems, cada uno con 4 alternativas de respuesta, de las cuales solo una corresponde a la respuesta correcta. El segundo instrumento es un cuestionario auto- dirigido que mide la adherencia al tratamiento antihipertensivo, compuesto por 13 ítems con 2 alternativas en cada uno, reflejando una respuesta positiva (indica adherencia al tratamiento) y una respuesta negativa (indica no se adhiere al tratamiento). (Ver anexo 1A)

Pasos para la recolección de datos

Para obtener la autorización para acceder a la población, se coordinará con la responsable del Centro de Salud Publico Materno Infantil de Surquillo, a quien se le enviará una solicitud formal para solicitar el acceso a los pacientes. En dicha solicitud, se requerirá la emisión de una base de datos con información sobre pacientes hipertensos, así como detalles sobre las normativas vigentes en el centro, con el objetivo de garantizar las medidas que protejan y seguridad de los participantes.

Cuando se tenga la autorización, se procederá a seleccionar a los pacientes que cumplan con los criterios de inclusión y exclusión establecidos en el estudio, a los cuales se les brindará el respeto correspondiente asegurándoles que la información brindada será completamente confidencial. Posteriormente, se les entregará el consentimiento

informado, el cual será leído y explicado detalladamente para asegurar que su participación sea completamente libre y voluntaria.

A aquellos que firmen el consentimiento, se les entregarán los cuestionarios para ser completados, indicándoles que respondan con sinceridad.

Al culminar el encuentro con los participantes se les entregará un pequeño detalle y se les agradecerá por su participación.

3.6 Plan de análisis e interpretación de la información

El análisis de los datos recolectados de los pacientes hipertensos será registrado en una base de datos utilizando el programa Excel y posteriormente, se transferirá al programa SPSS para el análisis estadístico. El análisis descriptivo, proporcionará una visión general de las características demográficas, de conocimiento y adherencia de la muestra.

El análisis inferencial se utilizará para establecer relaciones significativas entre las variables estudiadas. Este tipo de análisis permitirá evaluar las hipótesis y determinar si los patrones observados en la muestra pueden extrapolarse a la población general.

3.7 Ventajas y limitaciones

Ventajas

El diseño del estudio permite que la investigación se lleve a cabo en un periodo relativamente corto, lo cual optimiza el uso de recursos humanos, materiales y financieros, reduciendo así los costos asociados al proyecto. Además, se puede elegir a cualquier paciente hipertenso que asista a sus controles. Una de las principales ventajas de desarrollar este trabajo es la accesibilidad directa a la población objetivo, debido a que una de las investigadoras forma parte del personal del establecimiento. Esto facilita la coordinación con los responsables del centro de salud, agilizando los trámites administrativos.

Limitaciones

Que los días asignados para la aplicación de la encuesta no asistan los pacientes hipertensos al consultorio del centro de salud. Esta limitación puede afectar la representatividad de la muestra, ya que la ausencia de pacientes en los días previstos podría reducir el número de participantes disponibles. Para mitigar este inconveniente, se establecerán días alternativos de recolección de datos y se coordinará con los responsables del centro de salud para asegurar la asistencia de los pacientes.

Que los pacientes que participen no reciban la adecuada preparación antes del llenado de los cuestionarios. Para superar esta limitación, se llevará a cabo una sesión de orientación previa al llenado de los cuestionarios, en la que se explicará a los participantes el propósito del estudio, la importancia de sus respuestas y cómo deben responder de manera precisa y honesta. Además, se proporcionará un tiempo adecuado para que los participantes formulen preguntas en caso de dudas y se les aclarará cualquier aspecto del cuestionario antes de completar los instrumentos.

3.8 Aspectos éticos

El estudio será registrado en el Comité de Ética para su aprobación. Se brindará información sobre la finalidad y las características del trabajo de investigación a la encargada del Centro de Salud Materno Infantil de Surquillo y a los pacientes adultos hipertensos que deseen participar de la investigación, el propósito del trabajo es contribuir en el bienestar de la salud de los pacientes.

La participación en el estudio no generará ningún tipo de riesgo para la salud de los participantes, por lo que se enfoca en un estudio no experimental, descriptivo-correlacional. El instrumento de recolección de datos se aplicará a los adultos mayores de 18 años de ambos sexos que tengan hipertensión arterial y deseen participar, no se obligará a nadie a formar parte de este proyecto y no existirá discriminación respecto al idioma, condición social o creencias culturales, ya que todos los adultos son libres de elegir si desean participar o no del estudio, además, se respetará la confidencialidad y la privacidad de los datos de todos los encuestados. con la finalidad de conseguir datos relacionados a los conocimientos sobre la hipertensión arterial y la adherencia al tratamiento antihipertensivo.

3.9 Aspectos administrativos

Categoría de presupuesto	N°	Costo Unitario	Costo total
1. Recursos humanos			
Asesorías para proyecto de tesis	6	S/. 00 .00	S/. 00.00
Asesorías para informe de tesis	6	S/. 00.00	S/. 00.00
Validación por Jueces expertos	10	S/. 50.00	S/. 500.00
Asesorías en estadística	1	S/. 200.00	S/. 200.00
2. Recursos humanos			
Impresiones	500	s/. 0.50	S/. 250.00
fotocopias	250	s/. 0.30	S/. 75.00
Incentivos	150	s/. 3.00	S/. 450.00

Pasajes	20	s/. 4.00	S/. 80. 00
subtotal			
Total	S/. 1.555.00		

3.10. Cronograma de actividades

Actividades	2025									2026
	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1.- Selección del tema	X	X								
2.- Revisión de la bibliografía	X	X								
3.- Elaboración del proyecto	X	X								
4.- Registro del proyecto de tesis de investigación por parte del Departamento de investigación de la Facultad de ciencias de la salud			X							
5.- validación del Proyecto			X							
6.- Aprobación del comité de ética			X							
7.- Aplicación de la prueba piloto			X	X						
8.- Recolección de la información						X	X	X		
9.- Procesamiento de la información								X	X	X
10.- Análisis de interpretación de los resultados										X
11.- Elaboración de informe de investigación										X
12.- Presentación del informe										X
13.- Sustentación de tesis										X

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Fundación Española del Corazón. Presión Arterial. Madrid: Fundación Española del Corazón, 2023. [citado el 15 de julio de 2024] Disponible en: <https://fundaciondelcorazon.com/prensa/notas-de-prensa/2567-hipertension-mata-cada-ano-a-75-millones-de-personas-en-el-mundo.html>
2. La Organización Panamericana de la Salud. Enfermedades Cardiovasculares[Internet] [citado 25 de julio de 2024]. Disponible en: https://www.who.int/es/health-topics/cardiovascular-diseases#tab=tab_3
3. La Organización Mundial de Salud. Primer informe de la OMS sobre el impacto devastador de la hipertensión y formas de detenerla [Internet]. [Citado el 17 de julio de 2024]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news/item/19-09-2023-first-who-report-details-devastating-impact-of-hypertension-and-ways-to-stop-it>
4. Organización Mundial de la Salud. Mas de 700 millones de personas con hipertensión no tratada. [Internet]. Ginebra: OMS; 2021 [actualizado 2021 ago. 25] [citado el 18 de julio]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news/item/25-08-2021-more-than-700-million-people-with-untreated-hypertension>
5. Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Perú: Enfermedades no transmisibles, 2022 [Internet]. Lima: INEI;2022 [Citado el 18 de julio]. Disponible en:https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1734/cap01.pdf
6. Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI). Nota de prensa N°075-2020 [Internet]. Lima: INEI;2020 [Citado el 18 de Julio]. Disponible en: https://m.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/noticias/np75_2020.pdf
7. Recalde L. et al. Adherencia al tratamiento y nivel de conocimiento en adultos con hipertensión arterial, Asunción – Paraguay 2022. Rev. Virtual Soc.2023; [Internet]. [Citado el 18 de julio]. Disponible en: <https://www.revistaspmi.org.py/index.php/rvspmi/article/view/391/275>
8. Tirado A. Adherencia terapéutica y nivel de conocimiento de su enfermedad en pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial de la consulta externa. [Tesis de posgrado]. México: Benemérita Universidad Autónoma De Puebla; 2022; [Internet]. [Citado el 18 de julio]. Disponible en: <https://repositorioinstitucional.buap.mx/server/api/core/bitstreams/1d934515-78d3-4927-b948-f0550b9b5650/content>
9. Estrada D, et al. Grado de conocimiento de la hipertensión en pacientes hipertensos. Enfermería Clínica. 2020; 30(2): 61-8.DOI: págs. 99-107 [Internet]. [Citado el 18 de julio]. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1130862119300440?via%3Dihub>
10. Soplopuc M. Asociación entre conocimiento sobre hipertensión arterial y adherencia al tratamiento en pacientes hipertensos de centros de salud, Lambayeque. [Tesis de pregrado]. Lambayeque. Perú 2021: Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo [I internet]. [Citado el 19 de julio]. Disponible en: <https://repositorio.unprg.edu.pe/handle/20.500.12893/9222>

11. Marrufo- Gil. Nivel de conocimientos sobre hipertensión arterial y adherencia al tratamiento en pacientes hipertensos de un hospital de la selva peruana". Universidad Médica Pinareña. 2023 [Rev. Galeno.2023;23] [Internet]. [Citado el 19 de julio]. Disponible en: <https://revgaleno.sld.cu/index.php/ump/article/view/900/pdf>
12. Villamar M. Sergio M. Factores asociados a la adherencia terapéutica en pacientes con hipertensión arterial de la Unidad de Cardiología de Hospital III de Yanahuara [Tesis de pregrado]. Arequipa, Perú: Universidad Católica de Santa María; 2023. [Internet]. [Citado el 10 de febrero]. Disponible en: <https://repositorio.ucsm.edu.pe/items/fc70c92e-feba-4699-9fa6-d0135301640b>
13. Calle Chaparro, A. et al. Conocimientos, actitudes y adherencia al tratamiento en personas con diagnóstico de hipertensión arterial atendidos en un hospital de Lima, 2023 [Tesis de pregrado]. Lima: Universidad peruana de ciencias aplicadas de Perú; 2023 Disponible en el siguiente enlace: https://upc.aws.openrepository.com/bitstream/handle/10757/671514/Calle_CA.pdf?sequence=15&isAllowed=y
14. Rojas Atma. Conocimiento sobre factores de riesgo y adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes hipertensos del programa adulto mayor del hospital II Ramón Castilla, Lima, Perú. [Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar. Marzo- abril 2023. Volumen 7, Numero 2]. Disponible en: <https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/6074/9212>
15. Machado Reyes F, Casanova Moreno MC, Gonzales Casanova W, Casanova Moreno D, Ramírez Rodríguez M. Historia de Dorothea Orem y sus aportes a las teorías de la enfermería. [I Jornada de Secciones Provincial Capitulo Ciego de Ávila IJSSOCUENF 2023]. [Cuba]. [Internet]. [citado el 10 de febrero]. Disponible en: <https://promociondeeventos.sld.cu/jornadaseccionesenfermeriasocuenfciego2023/files/2023/03/Historia-de-Dorothea-Orem-y-sus-aportes-a-las-teorias-de-la-enfermeria.pdf>
16. [2024] [citado el 10 de febrero]. [Internet]. Disponible en: <https://www.nhlbi.nih.gov/health/high-blood-pressure>
17. [2024] [citado el 10 de febrero]. [Internet] Disponible en: https://www.heart.org/-/media/files/health-topics/answers-by-heart/answers-by-heart-spanish/what-is-highbloodpressure_span.pdf
18. Delgado - Galeno, M. Historia de presión arterial: revisión narrativa. Salud UIS [internet]. [mayo de 2023]. Colombia. Vol. 55, pp. 1-10. [Citado 10 de febrero] Disponible en: <https://www.redalyc.org/journal/3438/343876253072/>
19. CEUPE. European Business School. Tipos de conocimientos. Agosto de 2021. [Blog-Internet]. [Citado el 10 de febrero]. Disponible en: <https://www.ceupe.mx/blog/tipos-de-conocimientos.html>
20. Hurtado, F (2020). Fundamentos Metodológicos de la Investigación: El Génesis del Nuevo Conocimiento. Revista Científica,5(16), 99-199, e-ISSN;2542-2987. [Citado el 10 de febrero] Recuperado en: <https://www.redalyc.org/journal/5636/563662985006/563662985006.pdf>
21. Bermeo Pacheco J, Guerrero Jirón J, Delgado Santa Gadea K. Niveles del conocimiento. In: Procesos y fundamentos de la investigación científica.

- Angelpvelasco, Publisher.2020. p.51-100. [citado el 10 de febrero] disponible en: <https://anyflip.com/kgwsu/zyde/basic/51-100>
22. Curihuaman del Pino, K. et al. Conocimiento y cumplimiento sobre “lista de verificación de cirugía segura” por el equipo quirúrgico del hospital de huamanga - Ayacucho, 2021 [tesis de pregrado] [internet]. Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Perú. [Citado el 10 de febrero] Recuperado a partir de: <https://repositorio.unsch.edu.pe/server/api/core/bitstreams/d7c60cd0-6856-4d13-9d1f-83dc5b029621/content>
 23. Altamira Camacho R. Epistemología de la enfermería: de las visiones del mundo y su adecuación al método científico [Scielo]. [abril- 2023]. [Internet]. [Citado el 10 de febrero] Disponible en: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S169960112023000100012
 24. Chaudhry R, Miao JH, Rehman A. fisiología cardiovascular. En: National Library of Medicine. Treasure Island (FL): Stat Pearls Publishing; 16 de octubre de 2020 [Citado el 10 de febrero de 2025]. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/books/NBK493197/>
 25. Baños Vázquez JA. Sistema Cardiovascular, ¿Cómo funciona? Con- Ciencia Boletín Científico de la Escuela Preparatoria No. 3.2021;8(16): 7-9. [Citado el 10 de febrero de 2025]. Disponible en: <file:///C:/Users/hermy/Downloads/7327-Manuscrito-38726-1-10-20210422.pdf>
 26. Shahoud JS, Sanvictores T, Aeddula NR. Fisiología, regulación de la presión arterial. StatPearls [internet]. Treasure Island (FL): Stat Pearls Publishing;2023 Ago 28 [Citado 11 de febrero 2025]. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/books/NBK538509/>
 27. Lahera V, Cachofeiro V, de la Heras N. Capítulo 44: Regulación de presión arterial. En: Farreras Rozman. Medicina Interna.19ª ed. McGraw-Hill Education;2020 [citado el 11 de febrero del 2025]. Disponible en: <https://accessmedicina.mhmedical.com/content.aspx?bookid=1858§ionid=134366990>
 28. Bakris GL. Hipertensión arterial. En: MSD Manuals [Internet]. Kenilworth (NJ): Merck & Co., Inc;2023 septiembre [Citado el 11 de febrero del 2025]. Disponible en: <https://www.msdmanuals.com/es/hogar/trastornos-del-coraz%C3%B3n-y-los-vasos-sangu%C3%ADneos/hipertensi%C3%B3n-arterial/hipertensi%C3%B3n-arterial>
 29. Ministerio de Salud. ¿Qué es la hipertensión? Gop.pe. Actualizado junio 2024. [Internet]. [Citado el 11 de febrero del 2025]. Disponible en: <https://www.gob.pe/22569-que-es-la-hipertension>
 30. Ministerio de salud. Guía práctica clínica para prevención y control de la enfermedad hipertensiva en el primer nivel de atención. R.M. N° 491-2009/MINSA. Lima – Perú 2011. Recuperado a partir de: <https://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/2826.pdf>
 31. Santos, C. Hipertensión Arterial. [fbbva_libroCorazon_cap12.pdf] Madrid- España [Internet]. [Citado el 27 de agosto] disponible en: file:///C:/Users/hermy/Downloads/fbbva_libroCorazon_cap12.pdf

32. Alan Niell, D. Procesos y fundamentos de la investigación científica. Editorial UTMACH. Ecuador- 2017 [internet] Recuperado a partir de:
<https://repositorio.utmachala.edu.ec/bitstream/48000/14231/1/Cap.3-Niveles%20del%20conocimiento.pdf>
33. Pfizer. La adherencia al tratamiento: cumplimiento y constancia para mejorar la calidad de vida [Internet]. (Madrid- España). [Citado el 27 de agosto]. Disponible en:
<http://envejecimiento.csic.es/documentos/documentos/pfizer-adherencia-01.pdf>
34. Adherencia a los programas de prevención cardiovascular: un reto pendiente. Revista Española de Cardiología. 2020; 73(4): 349.357. [Scielo]. [Internet] [Citado el 27 de agosto]. Disponible en:
https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1699-714X2020000400009#:~:text=Los%20autores%20concluyen%20que%20la,objetivos%20de%20los%20programas%20cardiovasculares.
35. Pedrosa, I. Et al. Evidencias sobre la validez de contenido: avances teóricos y métodos para su estimación. Revista Acción Psicológica. Madrid 2013; Vol. 10. Nro.2 [Scielo]. [internet] Disponible en:
https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1578-908X2013000200002
36. Policarpo, A. La génesis del conocimiento: de la sensación a la razón. (2017). Redalyc.org. [Internet] Disponible en:
<https://www.redalyc.org/journal/356/35655222002/html/#:~:text=Arist%C3%B3teles%20afirma%20que%20el%20hombre,de%20conocimiento%20que%20son:%20el>
37. Cueva M. Factores asociados a la adherencia al tratamiento antihipertensivo en pacientes adultos de un hospital público de Lima [Tesis de pregrado]. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 2020.

Anexos

UNIVERSIDAD CATÓLICA SEDES SAPIENTIAE

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD



CONSENTIMIENTO INFORMADO

Estimado paciente: muy buenos días, somos las estudiantes Judith Mercado Sarmiento y Herminia De la Cruz Rodriguez, de la carrera profesional de Enfermería de la Universidad Católica Sedes Sapientiae. El presente instrumento tiene como finalidad obtener información acerca del nivel de conocimiento y adherencia al tratamiento antihipertensivo en adultos en un Centro de Salud Público, Lima -2025.

Le solicitamos su colaboración para nuestro trabajo de investigación. La información que nos proporcione será manejada de forma confidencial y con fines exclusivamente propios a la investigación, por lo que se requiere su total veracidad.

Yo _____ identificado con DNI _____; adulto con diagnóstico médico de hipertensión arterial, en pleno uso de mis derechos y habiendo sido informado de forma completa sobre el estudio, deseo colaborar libre y voluntariamente con el estudio de investigación titulado “Nivel de conocimiento y adherencia al tratamiento antihipertensivo en adultos en un Centro de Salud Público, Lima – 2025” dirigida por las estudiantes De La Cruz Rodriguez, Herminia y Mercado Sarmiento, Judith.

Por lo tanto, doy conformidad de mi participación en la encuesta.

Lima, De del 2025

Firma y huella

Anexo 1 (A)

FICHA DE DATOS SOBRE LOS ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS Y SOCIOECONÓMICOS

Estimado paciente: muy buenos días, somos las estudiantes Judith Mercado Sarmiento y Herminia De la Cruz Rodríguez, de la carrera profesional de Enfermería de la Universidad Católica Sedes Sapientiae. El presente instrumento tiene como finalidad obtener información acerca del nivel de conocimiento y adherencia al tratamiento antihipertensivo en adultos en un Centro de Salud Público, Lima -2025.

Le solicitamos su colaboración para nuestro trabajo de investigación. La información que nos proporcione será manejada de forma confidencial y con fines exclusivamente propios a la investigación, por lo que se requiere su total veracidad.

Aspectos sociodemográficos

- I. **Edad:** _____
- II. **Tiempo de enfermedad:** _____
- III. **Sexo:** Femenino () Masculino ()
- IV. **Residencia:** Urbano () Rural () Asentamiento humano ()
- V. **Raza:** Mestizo () Blanco () Afrodescendiente () Asiático ()
- VI. **Formación académica**
- Primaria completa ()
 - Secundaria completa ()
 - Superior completa ()
 - Sin estudio ()
- VII. **Estado civil:** Soltero () Casado () Conviviente () Viudo ()
- VIII. **¿Sus padres tienen o tuvieron Hipertensión?** Si () No ()

Aspectos socioeconómicos

- IX. **Situación laboral**
- Trabaja actualmente ()
 - Es jubilado ()
 - No trabaja ()
 - Recibe ayuda familiar ()
- X. **Régimen de salud**
- Tiene ESSALUD ()
 - Tiene SIS ()
 - Seguro particular ()
 - No tiene seguro ()

Anexo 1 (B)

CUESTIONARIO 01: NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL

Marca con un aspa (X) la respuesta correcta.

DIMENSIÓN: ASPECTOS GENERALES SOBRE EL CONOCIMIENTO

- 1. ¿Usted sabe que es la Hipertensión Arterial?**
 - a. Es una enfermedad que eleva la presión arterial sobre los valores normales y afecta al corazón.
 - b. Es una enfermedad que no eleva la presión arterial y sin afectar al corazón.
 - c. Es una enfermedad que baja la presión arterial y puede afectar al riñón
 - d. No es una enfermedad

- 2. La hipertensión arterial es una enfermedad que afecta:**
 - a. El sistema inmunológico y la piel.
 - b. Los pulmones y bronquios.
 - c. El corazón y las arterias.
 - d. El hígado y las venas.

- 3. Se considera hipertensión arterial cuando la presión está por encima de:**
 - a. 110/60 mmHg.
 - b. 140/90 mmHg.
 - c. 120/80 mmHg.
 - d. 90/70 mmHg

- 4. ¿Cuáles son los síntomas de la hipertensión arterial en una etapa avanzada?**
 - a. Dolor de cabeza, zumbido de oídos y mareos.
 - b. Palidez, hormigueo y sueño.
 - c. Irritación ocular y escozor.
 - d. No presenta síntomas.

- 5. En una complicación severa de la Hipertensión Arterial se puede presentar:**
 - a. Dolor de cabeza intenso y mareos
 - b. Pérdida de conciencia y sangrado por la nariz
 - c. Dificultad para respirar y zumbido de oído
 - d. Todas son correctas

- 6. ¿La edad juega un rol importante en el aumento de la presión arterial?**
 - a. Sí porque disminuye la capacidad de expandirse y contraerse los vasos sanguíneos

- b. No, la presión aumenta después de los 80 años.
- c. Sí, cuando no se alimenta bien
- d. Desconozco que aumenta con la edad.

7. Usted sabía que la Hipertensión Arterial:

- a. Es una enfermedad silenciosa y peligrosa
- b. No se cura
- c. La Hipertensión no se cura, pero se controla
- d. La Hipertensión Arterial se cura con hierbas

DIMENSIÓN: FACTORES DE RIESGO

8. ¿Usted considera que es un riesgo para padecer Hipertensión Arterial?

- a. Tener amigos con Hipertensión Arterial
- b. No tiene ningún factor de riesgo
- c. Tener padres que padecen de Hipertensión Arterial
- d. Tener bajo peso

9. ¿Qué acciones cree usted que aumentan el riesgo de padecer Hipertensión Arterial?

- a. No realizar actividad física, consumir alimentos alto en sal y beber alcohol
- b. Beber agua, comer verduras y frutas.
- c. Manejar bicicleta
- d. No hay acciones de riesgo para padecer la Hipertensión Arterial

10. Indique ¿Cuál es un factor de riesgo emocional de la Hipertensión Arterial?

- a. La felicidad y relajación
- b. La tranquilidad
- c. El estrés crónico y la ansiedad
- d. No tiene factor de riesgo emocional

11. ¿En la Hipertensión Arterial la obesidad es un factor de riesgo?

- a. No, la obesidad solo causa daño a los huesos
- b. La obesidad protege el cuerpo.
- c. Si, la obesidad aumenta el riesgo porque el corazón trabaja más
- d. No es un factor de riesgo

DIMENSIÓN: ACCIONES PREVENTIVAS

12. Con respecto a la alimentación ¿Para controlar la Hipertensión Arterial qué alimentos consume?

- a. Frutas, verduras, proteínas
- b. Cereales, frituras, y agua
- c. Verduras, galletas y gaseosas
- d. Frutas, embutidos y queques

13. ¿Qué actividades físicas nos ayudan a controlar la Hipertensión Arterial?

- a. Caminar 20 minutos a la semana

- b. Realizar una caminata de 30 minutos diarios u otra actividad física de acuerdo con la edad.
- c. Nos realizar ejercicio más de 5 minutos
- d. Permanecer sentada.

Anexo 1 (C)

CUESTIONARIO 02: ADHERENCIA AL TRATAMIENTO ANTIHIPERTENSIVO

Marca la respuesta con un aspa (X) que se ajuste a tu realidad.

N°	Preguntas sobre adherencia al tratamiento antihipertensivo	Si	No
1	¿Toma sus medicamentos a la hora indicada?		
2	¿Se olvida de tomar sus medicamentos?		
3	¿Alguna vez se quedó sin sus medicamentos por falta de dinero?		
4	¿Toma sus medicamentos junto con los alimentos?		
5	¿Usted acude a sus citas programadas para su control?		
6	¿Cuándo se siente bien, deja de tomar sus medicamentos?		
7	¿Después de la consulta médica obtiene sus medicamentos de inmediato para cumplir con su tratamiento?		
8	¿Para qué le alcance el tratamiento se salta algunas dosis del día?		
9	¿Si, el medicamento le produce mareo o dolor de cabeza deja de tomar su medicamento?		
10	En caso de que se olvide de tomar su pastilla de la HTA, ¿se toma dos pastillas juntas?		
11	¿Cuándo usted viaja por algunos días, lleva sus medicamentos de la HTA?		
12	¿Siente usted que es una molestia cumplir con el tratamiento?		
13	¿Cree usted que se puede controlar la hipertensión arterial sin medicamentos?		

ANEXO 2

MATRIZ DE CONSISTENCIA

TÍTULO: Nivel de conocimiento y adherencia al tratamiento antihipertensivo en adultos en un Centro de Salud Público, Lima - 2024

Problema de investigación	Objetivos de investigación	Hipótesis	Variables e indicadores	Población y muestra	Plan de análisis	Alcance y diseño	Instrumentos
Problema general: ¿Cuál es la relación entre el nivel de conocimiento de la HTA y la adherencia al tratamiento antihipertensivo en adultos en un Centro de Salud Público, Lima – 2025?	Objetivo general: Identificar la relación entre el nivel de conocimiento de la HTA y la adherencia al tratamiento antihipertensivo en adultos en un Centro de Salud Público, Lima – 2025.	Hipótesis Alterna Existe una relación significativa entre el nivel de conocimiento y la adherencia al tratamiento antihipertensivo en adultos en un Centro de Salud Público, Lima – 2024.	Variables principales 1.- Nivel de conocimiento sobre hipertensión arterial. Bajo (0-4) Medio (5-8) Alto (9-13) 2.- Adherencia al tratamiento antihipertensivo. Se adhiere (13) No se adhiere (<13) <u>Aspectos sociodemográficos</u> 1.- Edad 2.- Tiempo de enfermedad 3.- Sexo - Femenino - Masculino 4.- Residencia - Urbano - Asentamiento-humano - Rural 5.- Raza - Mestizo	Población y muestra: La población del presente estudio estará constituida por 150 adultos de un Centro de Salud Público, Lima -2024. Criterios de inclusión: Adultos hipertensos de ambos sexos del Centro de Salud Público, Lima -2024.	El vaciado de los datos se realizará mediante el Programa SPSS. Análisis descriptivo: Se utilizarán frecuencias y porcentajes para las variables categóricas. Análisis inferencial: La prueba estadística que se utilizará según la cantidad de	Tipo de investigación Básica Diseño de investigación Observacional (no experimental) de corte transversal Alcance de investigación Descriptivo Correlacional Enfoque de estudio: Cuantitativo	Cuestionario para el nivel de conocimientos de hipertensión arterial: Cuestionario autodirigido de 13 preguntas donde una es la correcta. Instrumento creado por: De La Cruz Rodríguez y Mercado Sarmiento
Problemas específicos: 1.- ¿Cuál es el nivel de conocimientos sobre la hipertensión arterial en adultos en un	Objetivos específicos: 1.- Identificar el nivel de conocimientos sobre la HTA en adultos en un Centro de Salud	Hipótesis Nula No existe una relación significativa					

Centro de Salud Público, Lima - 2025? 2.- ¿Cuál es el nivel de adherencia del tratamiento antihipertensivo en adultos en un Centro de Salud Público, Lima - 2025? 3.- ¿Cuáles son las características sociodemográficas de los pacientes diagnosticados con hipertensión arterial que asisten al Centro de Salud Público, Lima – 2025?	Público, Lima – 2025. 2.- Identificar el nivel de adherencia del tratamiento antihipertensivo en adultos en un Centro de Salud Público, Lima – 2025. 3.- Identificar las características sociodemográficas de los pacientes diagnosticados con hipertensión arterial que asisten al Centro de Salud Público, Lima – 2025.	entre el nivel de conocimiento y la adherencia al tratamiento antihipertensivo en adultos en un Centro de Salud Público, Lima – 2024.	• Blanco • Afrodescendiente • Asiático 6.-Formación académica • Primaria completa • Secundaria completa • Superior completa • Sin estudios 7.- Estado civil • Soltero • Casado • Conviviente • Viudo 8.- Antecedentes familiares • SI • NO <u>Aspectos socioeconómicos</u> 9.- Situación laboral • Trabajo actualmente • Es jubilado • No trabaja • Recibe ayuda familiar 10.- Régimen de salud • Tiene ESSALUD • Tiene SIS • Seguro particular • No tiene seguro	Criterios de exclusión * Adultos de 18 años con discapacidad auditiva y visual. * Adultos que no hablan el idioma o no pueden entender las instrucciones . * Adultos que no estén diagnosticados con hipertensión arterial. *Adultos con trastornos psiquiátricos.	participantes será la prueba Chi Cuadrado.	Cuestionario para adherencia al tratamiento antihipertensivo Cuestionario autodirigido de 13 preguntas donde tiene dos alternativas, Se adhiere o no se adhiere. Instrumento creado por: De La Cruz Rodriguez y Mercado Sarmiento
---	--	--	---	---	---	--

ANEXO 3 (A)

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES PRINCIPALES

VARIABLE	DEFINICIÓN	DIMENSIONES	CATEGORÍAS	INDICADORES	ITEMS	NATURALEZA DE LAS CATEGORÍAS	INSTRUMENTO
Nivel de conocimiento sobre hipertensión arterial	El conocimiento es la información almacenada mediante la experiencia o el aprendizaje adquirido de una persona a lo largo de su vida.	Generalidades del conocimiento de la hipertensión arterial	Bajo	0-4	1-13	Cualitativa politómica ordinal	Cuestionario para medir el nivel de conocimientos sobre la hipertensión arterial: Cuestionario autodirigido de 13 preguntas donde una es la correcta.
			Medio	5-8			
			Alto	9-13			
		Conocimiento sobre los Factores de riesgo de la hipertensión arterial	Bajo	0-4	1-13		
			Medio	5-8			
			Alto	9-13			
		Acciones preventivas sobre las complicaciones de la hipertensión arterial	Bajo	0-4	1-13		
			Medio	5-8			
			Alto	9-13			

ANEXO 3 (B)

VARIABLES	DEFINICIÓN	DIMENSIONES	CATEGORIA	INDICADORES		ITEMS	NATURALEZA DE LAS CATEGORÍAS	INSTRUMENTO
Adherencia al tratamiento antihipertensivo	La adherencia al tratamiento es el comportamiento de una persona con respecto a las recomendaciones acordadas con su médico tratante.	Mecanismos del comportamiento que explican la no adherencia y la adherencia terapéutica	Se adhiere	Si	13	1-13	Cualitativa Dicotómica nominal	Cuestionario para adherencia al tratamiento antihipertensivo
				No				
			No se adhiere	Si	< 13			
				No				

ANEXO 3 (C)
OPERACIONALIZACIÓN DE LOS ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS Y SOCIOECONÓMICOS

NOMBRES DE LAS VARIABLES	CLASIFICACIÓN SEGÚN LA NATURALEZA	ESCALA DE MEDICIÓN	CATEGORÍA	INDICADOR
Edad	Cuantitativa – continua	-	-	-
Tiempo de enfermedad	Cuantitativa – continua	-	-	-
Sexo	Cualitativa – dicotómica	Nominal	Femenino Masculino	1 2
Residencia	Cualitativa – politómica	Nominal	Urbano Asentamiento-humano Rural	1 2 3
Raza	Cualitativa – politómica	Nominal	Mestizo Blanco Afrodescendiente Asiático	1 2 3 4
Formación académica	Cualitativa – politómica	Ordinal	Primaria completa Secundaria completa Superior completa Sin estudios	1 2 3 4
Estado civil	Cualitativa – politómica	Nominal	Soltero Casado Conviviente Viudo	1 2 3 4
¿Sus padres tienen o tuvieron HTA?	Cualitativa – dicotómica	Nominal	Si No	1 2
Situación laboral	Cualitativa – politómica	Nominal	Trabajo actualmente Es jubilado No trabaja Recibe ayuda familiar	1 2 3 4
Régimen de salud	Cualitativa – politómica	Nominal	Tiene ESSALUD Tiene SIS Seguro particular No tiene seguro	1 2 3 4

Anexo 4 Jueces expertos

Nombre del experto: M.C. Karen Mamani Vargas

Cargo: Medicina General

ASPECTOS DE VALIDACIÓN

Instrucciones: Determinar si el instrumento de medición reúne los indicadores mencionados, evaluar de acuerdo a la siguiente escala: Muy bueno (81 a 100%), bueno (61 a 80%), regular (41 a 60%), malo (21 a 40%) y muy malo (1 a 20%). Coloque un aspa (x) en el casillero correspondiente.

Nº	Indicaciones	Definición	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo	Muy malo
1	Consistencia	Las preguntas son adecuadas en relación con todas las partes que forman un todo.		✓			
2	Pertinencia	Las preguntas son convenientes y oportunas.		✓			
3	Validez	Las preguntas son correctas, eficaces y se ajustan a la ley: valor.	✓				
4	Organización	Las preguntas se han estructurado con orden y de acuerdo a los indicadores propuestos.	✓				
5	Claridad	Las preguntas están redactadas con expresiones que el encuestado entiende.	✓				
6	Precisión	Las preguntas son exactas o precisas.	✓				
7	Actualidad	Las preguntas son adecuadas al avance de la ciencia y tecnología.	✓				
8	Coherencia	Las preguntas tienen coherencia con los indicadores y dimensiones.	✓				
9	Metodología	El instrumento responde al propósito del estudio.	✓				
10	Suficiencia	Comprende los aspectos en cantidad y calidad.	✓				
	Promedio de validación en %						

OPINIONES DE APLICABILIDAD: _____

DNI. N° 4529790

Firma del experto informante.


 Karen Mamani Vargas
 MEDICO CIRUJANO
 CMP 069679

Nombre del experto: M.R. Kevin López Bernaola
Cargo: Medicina Familiar y Comunitaria

2

ASPECTOS DE VALIDACIÓN

Instrucciones: Determinar si el instrumento de medición reúne los indicadores mencionados, evaluar de acuerdo a la siguiente escala: Muy bueno (81 a 100%), bueno (61 a 80%), regular (41 a 60%), malo (21 a 40%) y muy malo (1 a 20%). Coloque un aspa (x) en el casillero correspondiente.

N°	Indicaciones	Definición	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo	Muy malo
1	Consistencia	Las preguntas son adecuadas en relación con todas las partes que forman un todo.	94				
2	Pertinencia	Las preguntas son convenientes y oportunas.	92				
3	Validez	Las preguntas son correctas, eficaces y se ajustan a la ley de valor.	94				
4	Organización	Las preguntas se han estructurado con orden y de acuerdo a los indicadores propuestos.	96				
5	Claridad	Las preguntas están redactadas con expresiones que el encuestado entiende	92				
6	Precisión	Las preguntas son exactas o precisas.	92				
7	Actualidad	Las preguntas son adecuadas al avance de la ciencia y tecnología	90				
8	Coherencia	Las preguntas tienen coherencia con los indicadores y dimensiones.	94				
9	Metodología	El instrumento responde al propósito del estudio	92				
10	Suficiencia	Comprende los aspectos en cantidad y calidad	94				
Promedio de validación en %			93%				

OPINIONES DE APLICABILIDAD: Aplicable

DNI N° 70147635

Firma del experto informante: _____


 Dr. López Bernaola Kevin A.
 M.R. Medicina Familiar y Comunitaria
 C.M.P. 1003439

Nombre del experto: Dra. Margarita Susana Silva Dávila.

Cargo: Coordinadora de la sede UNMSM – Medicina Familiar y Comunitaria

ASPECTOS DE VALIDACIÓN

Instrucciones: Determinar si el instrumento de medición reúne los indicadores mencionados, evaluar de acuerdo a la siguiente escala: Muy bueno (81 a 100%), bueno (61 a 80%), regular (41 a 60%), malo (21 a 40%) y muy malo (1 a 20%). Coloque un aspa (x) en el casillero correspondiente.

Nº	Indicaciones	Definición	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo	Muy malo
1	Consistencia	Las preguntas son adecuadas en relación con todas las partes que forman un todo.	X				
2	Pertinencia	Las preguntas son convenientes y oportunas.	X				
3	Validez	Las preguntas son correctas, eficaces y se ajustan a la ley: valor.	X				
4	Organización	Las preguntas se han estructurado con orden y de acuerdo a los indicadores propuestos.	X				
5	Claridad	Las preguntas están redactadas con expresiones que el encuestado entiende.	X				
6	Precisión	Las preguntas son exactas o precisas.	X				
7	Actualidad	Las preguntas son adecuadas al avance de la ciencia y tecnología.	X				
8	Coherencia	Las preguntas tienen coherencia con los indicadores y dimensiones.	X				
9	Metodología	El instrumento responde al propósito del estudio.	X				
10	Suficiencia	Comprende los aspectos en cantidad y calidad.	X				
Promedio de validación en %			81-100%				

OPINIONES DE APLICABILIDAD: El instrumento a utilizar cumple con los indicadores de Validez.

DNI N° 09158213

Firma del experto informante: [Firma]

[Firma]
Margarita Susana Silva Dávila
CMP 65675 RNE 33209
Coordinadora de sede UNMSM
Medicina Familiar y Comunitaria
CSMI Surquillo - DIRIS Lima Centro

Nombre del experto: Dra. Nélida Cirila Avilés Alfaro.
Cargo: Medico Cirujano

ASPECTOS DE VALIDACIÓN

Instrucciones: Determinar si el instrumento de medición reúne los indicadores mencionados, evaluar de acuerdo a la siguiente escala: Muy bueno (81 a 100%), bueno 61 a 80%), regular (41 a 60%), malo (21 a 40%) y muy malo (1 a 20%). Coloque un aspa (x) en el casillero correspondiente.

Nº	Indicaciones	Definición	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo	Muy malo
1	Consistencia	Las preguntas son adecuadas en relación con todas las partes que forman un todo.		✓			
2	Pertinencia	Las preguntas son convenientes y oportunas.	✓				
3	Validez	Las preguntas son correctas, eficaces y se ajustan a la ley: valor.		✓			
4	Organización	Las preguntas se han estructura con orden y de acuerdo a los indicadores propuestos.	✓				
5	Claridad	Las preguntas están redactadas con expresiones que el encuestado entiende.	✓				
6	Precisión	Las preguntas son exactas o precisas.		✓			
7	Actualidad	Las preguntas son adecuadas al avance de la ciencia y tecnología.	✓				
8	Coherencia	Las preguntas tienen coherencia con los indicadores y dimensiones.	✓				
9	Metodología	El instrumento responde al propósito del estudio.	✓				
10	Suficiencia	Comprende los aspectos en cantidad y calidad.	✓				
	Promedio de validación en %						

OPINIONES DE APLICABILIDAD: Si

DNI. Nº 21426140

Firma del experto informante.

Nelida C. Aviles Alfaro
 MEDICO CIRUJANO
 C.M.P. N° 57663

Nombre del experto: André Martin Barahona Sifuentes

Cargo: Medicina General

ASPECTOS DE VALIDACIÓN

Instrucciones: Determinar si el instrumento de medición reúne los indicadores mencionados, evaluar de acuerdo a la siguiente escala: Muy bueno (81 a 100%), bueno (61 a 80%), regular (41 a 60%), malo (21 a 40%) y muy malo (1 a 20%). Coloque un aspa (x) en el casillero correspondiente.

Nº	Indicaciones	Definición	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo	Muy malo
1	Consistencia	Las preguntas son adecuadas en relación con todas las partes que forman un todo.	X				
2	Pertinencia	Las preguntas son convenientes y oportunas.	X				
3	Validez	Las preguntas son correctas, eficaces y se ajustan a la ley: valor.	X				
4	Organización	Las preguntas se han estructurado con orden y de acuerdo a los indicadores propuestos.	X				
5	Claridad	Las preguntas están redactadas con expresiones que el encuestado entiende.	X				
6	Precisión	Las preguntas son exactas o precisas.	X				
7	Actualidad	Las preguntas son adecuadas al avance de la ciencia y tecnología.	X				
8	Coherencia	Las preguntas tienen coherencia con los indicadores y dimensiones.	X				
9	Metodología	El instrumento responde al propósito del estudio.	X				
10	Suficiencia	Comprende los aspectos en cantidad y calidad.	X				
Promedio de validación en %							

OPINIONES DE APLICABILIDAD: *El instrumento de medición es aplicable para su propósito*

DNI. Nº 46656751

Firma del experto informante.

[Firma]
MC. BARAHONA SIFUENTES ANDRÉ
CMP. 78242

Cargo: Servicio de enfermería

Instrucciones: Determinar si el instrumento de medición reúne los indicadores mencionados, evaluar de acuerdo a la siguiente escala: Muy bueno (81 a 100%), bueno (61 a 80%), regular (41 a 60%), malo (21 a 40%) y muy malo (1 a 20%). Coloque un aspa (x) en el casillero correspondiente.

Nº	Indicaciones	Definición	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo	Muy malo
1	Consistencia	Las preguntas son adecuadas en relación con todas las partes que forman un todo.		✓			
2	Pertinencia	Las preguntas son convenientes y oportunas.	✓				
3	Validez	Las preguntas son correctas, eficaces y se ajustan a la ley: valor.		✓			
4	Organización	Las preguntas se han estructurado con orden y de acuerdo a los indicadores propuestos.		✓			
5	Claridad	Las preguntas están redactadas con expresiones que el encuestado entiende.		✓			
6	Precisión	Las preguntas son exactas o precisas.	✓				
7	Actualidad	Las preguntas son adecuadas al avance de la ciencia y tecnología.	✓				
8	Coherencia	Las preguntas tienen coherencia con los indicadores y dimensiones.	✓				
9	Metodología	El instrumento responde al propósito del estudio.	✓				
10	Suficiencia	Comprende los aspectos en cantidad y calidad.	✓				
	Promedio de validación en %						

DNI. Nº 06675996

MINISTERIO DE SALUD
SECRETARÍA DE POLÍTICA Y PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA

6. CECILIA VERONICA DE LA LOPEZ
D.E. # 6609 N.Y. 19261

Nombre del experto: Raúl Martín Castañeda Marín
Cargo: Medicina General

ASPECTOS DE VALIDACIÓN

Instrucciones: Determinar si el instrumento de medición reúne los indicadores mencionados, evaluar de acuerdo a la siguiente escala: Muy bueno (81 a 100%), bueno (61 a 80%), regular (41 a 60%), malo (21 a 40%) y muy malo (1 a 20%). Coloque un aspa (x) en el casillero correspondiente.

Nº	Indicaciones	Definición	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo	Muy malo
1	Consistencia	Las preguntas son adecuadas en relación con todas las partes que forman un todo.	X				
2	Pertinencia	Las preguntas son convenientes y oportunas.	X				
3	Validez	Las preguntas son correctas, eficaces y se ajustan a la ley: valor.	X				
4	Organización	Las preguntas se han estructurado con orden y de acuerdo a los indicadores propuestos.	X				
5	Claridad	Las preguntas están redactadas con expresiones que el encuestado entiende.	X				
6	Precisión	Las preguntas son exactas o precisas.	X				
7	Actualidad	Las preguntas son adecuadas al avance de la ciencia y tecnología.	X				
8	Coherencia	Las preguntas tienen coherencia con los indicadores y dimensiones.	X				
9	Metodología	El instrumento responde al propósito del estudio.	X				
10	Suficiencia	Comprende los aspectos en cantidad y calidad.	X				
Promedio de validación en %							

OPINIONES DE APLICABILIDAD: _____

DNI. N° 08186877

Firma del experto informante. _____

MINISTERIO DE SALUD
 DIRECCIÓN DE REDES HOSPITALARIAS DE SALUD LIMA CENTRO
 CENTRO DE SALUD BELLAVISTA
 DR. RAÚL MARTÍN CASTAÑEDA MARÍN
 MÉDICO ASISTENCIAL
 C.M.P. 33428

Nombre del experto: Lic. Yuliana Rosa Vallejos Tapia

Cargo: Responsable del servicio de enfermería

ASPECTOS DE VALIDACIÓN

Instrucciones: Determinar si el instrumento de medición reúne los indicadores mencionados, evaluar de acuerdo a la siguiente escala: Muy bueno (81 a 100%), bueno (61 a 80%), regular (41 a 60%), malo (21 a 40%) y muy malo (1 a 20%). Coloque un aspa (x) en el casillero correspondiente.

Nº	Indicaciones	Definición	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo	Muy malo
1	Consistencia	Las preguntas son adecuadas en relación con todas las partes que forman un todo.	✓				
2	Pertinencia	Las preguntas son convenientes y oportunas.	✓				
3	Validez	Las preguntas son correctas, eficaces y se ajustan a la ley: valor.	✓				
4	Organización	Las preguntas se han estructurado con orden y de acuerdo a los indicadores propuestos.	✓				
5	Claridad	Las preguntas están redactadas con expresiones que el encuestado entiende.	✓				
6	Precisión	Las preguntas son exactas o precisas.	✓				
7	Actualidad	Las preguntas son adecuadas al avance de la ciencia y tecnología.	✓				
8	Coherencia	Las preguntas tienen coherencia con los indicadores y dimensiones.	✓				
9	Metodología	El instrumento responde al propósito del estudio.	✓				
10	Suficiencia	Comprende los aspectos en cantidad y calidad.	✓				
	Promedio de validación en %						

OPINIONES DE APLICABILIDAD: Este instrumento es válido

DNI. N° 06780805

Firma del experto informante.

MINISTERIO DE SALUD
Dirección de Redes Integradas Lima Centro
Yuliana Rosa Vallejos Tapia
Lic. Yuliana Rosa Vallejos Tapia
CEP.033357 REE.10006 REE.001113

Nombre del experto: Dra. Úrsula Zerpa Valera
Cargo: Medicina General

ASPECTOS DE VALIDACIÓN

Instrucciones: Determinar si el instrumento de medición reúne los indicadores mencionados, evaluar de acuerdo a la siguiente escala: Muy bueno (81 a 100%), bueno (61 a 80%), regular (41 a 60%), malo (21 a 40%) y muy malo (1 a 20%). Coloque un aspa (x) en el casillero correspondiente.

Nº	Indicaciones	Definición	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo	Muy malo
1	Consistencia	Las preguntas son adecuadas en relación con todas las partes que forman un todo.	✓				
2	Pertinencia	Las preguntas son convenientes y oportunas.	✓				
3	Validez	Las preguntas son correctas, eficaces y se ajustan a la ley: valor.	✓				
4	Organización	Las preguntas se han estructurado con orden y de acuerdo a los indicadores propuestos.	✓				
5	Claridad	Las preguntas están redactadas con expresiones que el encuestado entiende.	✓				
6	Precisión	Las preguntas son exactas o precisas.	✓				
7	Actualidad	Las preguntas son adecuadas al avance de la ciencia y tecnología.	✓				
8	Coherencia	Las preguntas tienen coherencia con los indicadores y dimensiones.	✓				
9	Metodología	El instrumento responde al propósito del estudio.	✓				
10	Suficiencia	Comprende los aspectos en cantidad y calidad.	✓				
Promedio de validación en %			100%				

OPINIONES DE APLICABILIDAD: _____

DNI. N° 77208758

Firma del experto informante. _____


Dra. Úrsula Zerpa Valera
MÉDICO GENERAL
 CMP: 099949

Nombre del experto: Lic. Katerin Yesika Olivera Guevara
Cargo: Enfermera de salud comunitaria

ASPECTOS DE VALIDACIÓN

Instrucciones: Determinar si el instrumento de medición reúne los indicadores mencionados, evaluar de acuerdo a la siguiente escala: Muy bueno (81 a 100%), bueno (61 a 80%), regular (41 a 60%), malo (21 a 40%) y muy malo (1 a 20%). Coloque un aspa (x) en el casillero correspondiente.

Nº	Indicaciones	Definición	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo	Muy malo
1	Consistencia	Las preguntas son adecuadas en relación con todas las partes que forman un todo.		X			
2	Pertinencia	Las preguntas son convenientes y oportunas.		X			
3	Validez	Las preguntas son correctas, eficaces y se ajustan a la ley: valor.			X		
4	Organización	Las preguntas se han estructurado con orden y de acuerdo a los indicadores propuestos.		X			
5	Claridad	Las preguntas están redactadas con expresiones que el encuestado entiende.			X		
6	Precisión	Las preguntas son exactas o precisas.		X			
7	Actualidad	Las preguntas son adecuadas al avance de la ciencia y tecnología.			X		
8	Coherencia	Las preguntas tienen coherencia con los indicadores y dimensiones.		X			
9	Metodología	El instrumento responde al propósito del estudio.			X		
10	Suficiencia	Comprende los aspectos en cantidad y calidad.			X		
	Promedio de validación en %						

OPINIONES DE APLICABILIDAD: TENER EN CUENTA A QUE POBLACIÓN VA DIRIGIDA Y NO SER TAN TÉCNICAS EN LA FORMULACIÓN DE LAS PREGUNTAS.

DNI. Nº 45924204

Firma del experto informante.

MINISTERIO DE SALUD
 DIRECCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA
 CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN
 LIC. KATERIN YESIKA OLIVERA GUEVARA
 CEP 71083

ANEXO 5

Validación de instrumento: Coeficiente V de AIKEN

Ficha de resumen de la opinión de expertos:

Criterios	Juez 1	Juez 2	Juez 3	Juez 4	Juez 5	Juez 6	Juez 7	Juez 8	Juez 9	Juez 10	V de AIKEN
1	4	5	5	4	5	4	5	5	5	4	0.92
2	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	0.96
3	5	5	5	4	5	4	5	5	5	3	0.92
4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	0.96
5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	3	0.94
6	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	0.96
7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	0.96
8	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	0.98
9	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	0.96
10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	0.96
TOTAL											0.95

El coeficiente de validez de contenido: $0.40 \leq CVc < 0,60$ (muy baja); $0,60 \leq CVc < 0,70$ (baja); $0,70 \leq CVc < 0,80$ (Moderadamente baja); $0,80 \leq CVc < 0,90$ (Buena); $0,90 \leq CVc \leq 1$ (Excelente) (32)

La validación del instrumento se realizó por medio del juicio de expertos, con los puntajes obtenidos se analizó la V de Aiken obteniendo un valor de 0.95, lo que indica un alto grado de validez de contenido.



Nº Reg.: CE-1999

Los Olivos, 18 de junio del 2025

**CARTA DE APROBACIÓN DEL PROTOCOLO DE TESIS POR EL COMITÉ DE ÉTICA EN
INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD**

Srtas.

De la Cruz Rodríguez, Herminia

Mercado Sarmiento, Judith

Por medio de la presente me permito hacer de su conocimiento que se ha realizado la revisión de su trabajo de tesis.

“Nivel de Conocimiento y adherencia al tratamiento antihipertensivo en adultos en un Centro de Salud Público, Lima - 2025”.

Cuya asesora es la Prof. Guillermina Valdivia Arce. Se emite la presente CARTA DE APROBACIÓN, a fin de que prosigan con los trámites correspondientes en la elaboración de su trabajo de tesis.

Sin otro particular me despido de usted.

Atentamente.

Dr. Luis Quiroz Avilés

Comité de Ética en Investigación